

Peran *Mindfulness-Based Stress Reduction* Untuk Stress, Tekanan darah dan Kualitas Hidup Pada Penderita Hipertensi

Erni Tri Indarti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Puji Astutik, S.Kep., Ns., M.Kes.



Peran Mindfulness-Based Stress Reduction Untuk Stress, Tekanan darah dan Kualitas Hidup Pada Penderita Hipertensi

Penulis:

Erni Tri Indarti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Puji Astutik, S.Kep., Ns., M.Kes.



Optimal
Untuk
Negeri

Peran Mindfulness-Based Stress Reduction Untuk Stress, Tekanan darah dan Kualitas Hidup Pada Penderita Hipertensi

Penulis: Erni Tri Indarti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Puji Astutik, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Mhamad Rizki Alamsyah, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-94-4
Terbit: September 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Peran Mindfulness-Based Stress Reduction Untuk Stress, Tekanan darah dan Kualitas Hidup Pada Penderita Hipertensi.” Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya prevalensi hipertensi di tingkat global maupun nasional, yang hingga saat ini masih menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Kompleksitas hipertensi tidak hanya terletak pada aspek fisiologis berupa peningkatan tekanan darah, melainkan juga berhubungan erat dengan faktor psikologis, khususnya stres, serta berdampak pada menurunnya kualitas hidup penderitanya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendekatan komplementer dan integratif dalam bidang kesehatan semakin mendapat perhatian. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), suatu metode intervensi berbasis kesadaran penuh yang dikembangkan untuk membantu individu mengelola stres secara adaptif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa MBSR berpotensi menurunkan tekanan darah, mengurangi tingkat stres psikologis, serta meningkatkan kualitas hidup pada penderita hipertensi. Hal inilah yang menjadi alasan utama penulis mengangkat tema tersebut, dengan harapan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai pentingnya intervensi non-farmakologis dalam pengelolaan hipertensi secara holistik.

Buku ini disusun berdasarkan telaah literatur ilmiah terkini dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kesehatan, maupun masyarakat umum. Bagi kalangan akademisi, buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan kajian interdisipliner di bidang kesehatan. Bagi praktisi, buku ini diharapkan memberikan inspirasi dalam penerapan intervensi berbasis mindfulness sebagai pelengkap terapi medis. Sementara itu, bagi masyarakat, buku ini dapat menjadi panduan awal untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan masukan, motivasi, dan dorongan moral. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi, sekaligus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan holistik.

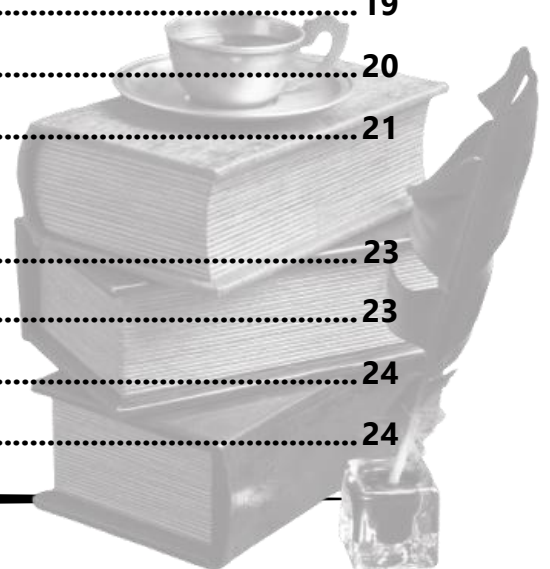
September, 2025

Penulis

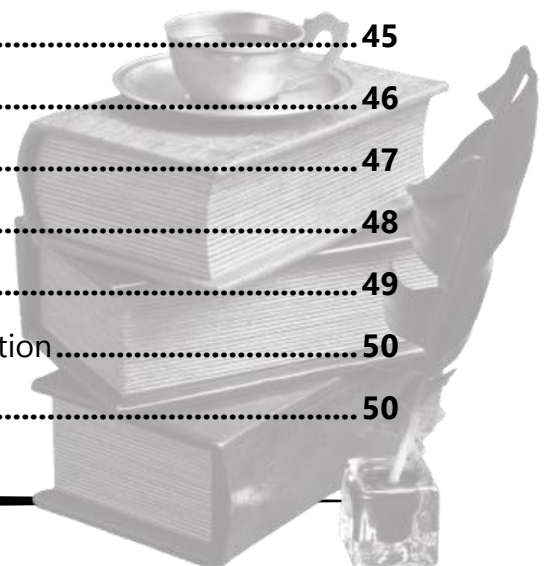


DAFTAR ISI

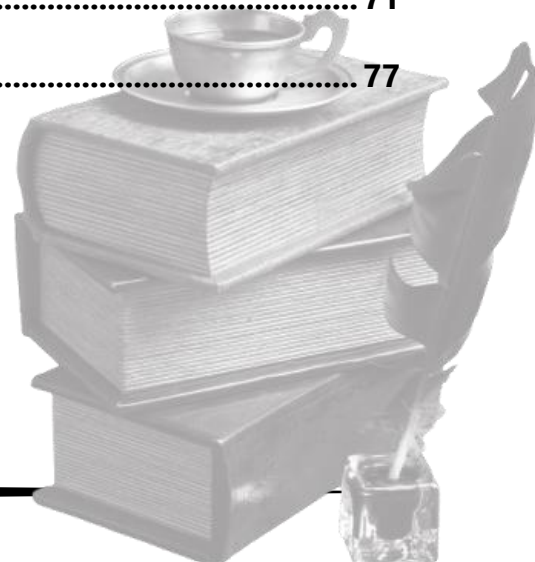
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP HIPERTENSI.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian	2
C. Klasifikasi Hipertensi.....	2
D. Etiologi Hipertensi.....	3
E. Manifestasi Klinis Hipertensi	7
F. Faktor Resiko Hipertensi	8
G. Patofisiologi Hipertensi	10
H. Pemeriksaan Penunjang Hipertensi	12
I. Penatalaksanaan Hipertensi	14
BAB 2 KONSEP STRESS.....	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Pengertian	17
C. Sumber Stress.....	18
D. Tingkatan Stress	18
E. Indikator Stress.....	19
F. Respon Tubuh Terhadap Stress	20
G. Alat Ukur Tingkat Stress.....	21
BAB 3 KONSEP TEKanan DARAH.....	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Pengertian	24
C. Jenis Tekanan Darah.....	24



D. Fisiologi Tekanan Darah	24
E. Faktor Mempengaruhi Tekanan Darah	26
F. Faktor Mempengaruhi Tekanan Darah	28
G. Upaya Agar Tekanan Darah Terkontrol.....	28
H. Komplikasi Tekanan Darah	29
BAB 4 KONSEP KUALITAS HIDUP	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Pengertian	31
C. Jenis-Jenis Kualitas Hidup	33
D. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup.....	34
E. Alat Ukur Kualitas Hidup	36
BAB 5 KONSEP MINDFULNES TERAPI	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Pengertian	40
C. Jenis	40
D. Antecedent Mindfulness	42
E. Manfaat Mindfulness Therapy	42
F. Mekanisme Kerja Mindfulness	42
G. Indikasi dan Kontraindikasi Mindfulness Therapy	43
BAB 6 KONSEP MINDFULNES BASED STRESS REDUCATION	45
A. Pendahuluan.....	45
B. Pengertian	46
C. Tujuan.....	47
D. Manfaat	48
E. Aspek Mindfulness -Based Stress Reduction.....	49
F. Komponen Utama Mindfulness -Based Stress Reduction.....	50
G. Prinsip Dasar Mindfulness-Based Stress Reduction	50



H. Tahapan Mindfulness-Based Stress Reduction.....	50
I. Mekanisme Kerja Mindfulness-Based Stress Reduction.....	51
J. Indikasi Mindfulness-Based Stress Reduction	52
K. Kontraindikasi Mindfulness-Based Stress Reduction.....	53
BAB 7 MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION UNTUK STRESS PENDERITA HIPERTENSI.....	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Penelitian Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Stress Pada Penderita Hipertensi.....	56
BAB 8 MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION UNTUK TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Penelitian Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi.....	60
BAB 9 MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION UNTUK KUALITAS HIDUP PENDERITA HIPERTENSI	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Penelitian Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Kualitas Hidup Pada Penderita Hipertensi.....	64
PENUTUP	69
REFERENSI.....	71
PROFIL PENULIS	77



BAB 1

KONSEP HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia. Data World Health Organization (WHO) tahun 2023 menyebutkan bahwa sekitar 1,28 miliar orang di dunia hidup dengan hipertensi, dan lebih dari 700 juta di antaranya tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat. Di Indonesia sendiri, prevalensi hipertensi berdasarkan Riskesdas 2018 mencapai 34,1% dan terus menunjukkan tren peningkatan². Prevalensi hipertensi menurut SKI 2023 sebanyak 30,8 %, 14,43% penderita hipertensi yang mengonsumsi obat secara teratur dan 13,34% yang melakukan kunjungan ulang ke pelayanan kesehatan. Jumlah penderita hipertensi di Puskesmas Loceret tahun 2024 6.082 orang dari total penduduk 57.615 orang dan di Desa Nglaban sebanyak 75 orang. Penatalaksanaan hipertensi selama ini yang dilakukan oleh pelayanan Kesehatan hanya mengarah ke pengendalian faktor fisik dan perubahan gaya hidup. Hipertensi tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik dan gaya hidup, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres dan kecemasan. Stres berkepanjangan dapat memicu aktivasi sistem saraf simpatis yang berujung pada peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, pengelolaan stres menjadi salah satu komponen penting dalam upaya menurunkan tekanan darah dan mencegah komplikasi pada pasien hipertensi.

B. Pengertian

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Penderita hipertensi merupakan pasien dengan risiko tertinggi terjadinya penyakit stroke dan penyakit kardiovaskular, data dari WHO (World Health Organization) pada tahun 2013.

Hipertensi secara umum dapat didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah manusia secara alami berfluktuasi sepanjang hari. Tekanan darah tinggi menjadi masalah hanya bila tekanan darah tersebut persisten. Tekanan darah tersebut membuat sistem sirkulasi dan organ yang mendapat suplai darah (termasuk jantung dan otak) menjadi tegang. Menurut WHO batas normal tekanan darah adalah 120-140 mmHg tekanan sistolik dan 80-90 mmHg tekanan diastolik. Hipertensi pada lansia didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka. Angka yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi (sistolik), angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berelaksasi (diastolik). Tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg didefinisikan sebagai "normal". Pada tekanan darah tinggi, biasanya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Hipertensi biasanya terjadi pada tekanan darah 140/90 mmHg atau ke atas, diukur di kedua lengan tiga kali dalam jangka beberapa minggu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan keadaan tekanan darah yang sama atau melebihi 140 mmHg sistolik dan/atau sama atau melebihi 90 mmHg diastolik (Alfeus, 2018).

C. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi hipertensi atau tekanan darah tinggi menurut Alfeus (20018), terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hipertensi esensial (primer) Tipe ini terjadi pada sebagian besar kasus tekanan darah tinggi, sekitar 95%. Penyebabnya tidak diketahui dengan jelas, walaupun

dikaitkan dengan kombinasi faktor pola hidup seperti kurang bergerak dan pola makan.

2. Hipertensi sekunder Tipe ini lebih jarang terjadi, hanya sekitar 5% dari seluruh kasus tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tipe ini disebabkan oleh kondisi medis lain (misalnya penyakit ginjal) atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu (misalnya pil KB).

Menurut Alfeus (2018), hipertensi pada usia lanjut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hipertensi dimana tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 90 mmHg.
2. Hipertensi sistolik terisolasi dimana tekanan sistolik lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg.

Tabel 1.1 Hipertensi Sistolik

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	≤ 130 mmHg	≤ 85 mmHg
Normal tinggi	130-139 mmHg	85-89 mmHg
Hipertensi ringan	140-159 mmHg	90-99 mmHg
Hipertensi sedang	160-179 mmHg	100-109 mmHg
Hipertensi berat	180-209 mmHg	110-119 mmHg
Hipertensi maligna	≥ 210 mmHg	≥ 120 mmHg

D. Etiologi Hipertensi

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu (Alfeus, 2018):

1. Hipertensi esensial atau primer

Penyebab pasti dari hipertensi esensial sampai saat ini masih belum dapat diketahui. Namun, berbagai faktor diduga turut berperan sebagai penyebab

hipertensi primer, seperti bertambahnya umur, stres psikologis, dan hereditas (keturunan). Kurang lebih 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi primer, sedangkan 10%-nya tergolong hipertensi sekunder.

2. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal (hiperaldosteronisme), dan lain lain. Karena golongan terbesar dari penderita hipertensi adalah hipertensi esensial, maka penyelidikan dan pengobatan lebih banyak ditujukan ke penderita hipertensi esensial.

Beberapa penyebab terjadinya hipertensi sekunder:

- a. Penyakit ginjal
- b. Stenosis arteri renalis
- c. Pielonefritis
- d. Glomerulonefritis
- e. Tumor-tumor ginjal
- f. Penyakit ginjal polikista (biasanya diturunkan)
- g. Trauma pada ginjal (luka yang mengenai ginjal)
- h. Terapi penyinaran yang mengenai ginjal
- i. Kelainan hormonal
- j. Hiperaldosteronisme
- k. Sindroma cushing
- l. Feokromositoma
- m. Obat-obatan
- n. Pil KB
- o. Kortikosteroid
- p. Siklosporin
- q. Eritropoietin
- r. Kokain
- s. Penyalahgunaan alkohol

- t. Kayu manis (dalam jumlah sangat besar)
- u. Koartasio aorta
- v. Preeklamsi pada kehamilan
- w. Porfiria intermiten akut
- x. Keracunan timbal akut

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hipertensi:

1. Umur

Orang yang berumur 40 tahun biasanya rentan terhadap meningkatnya tekanan darah yang lambat laun dapat menjadi hipertensi seiring dengan bertambahnya umur mereka

2. Ras/Suku

Di luar negeri orang kulit hitam kulit putih. Karena adanya perbedaan status/derajat ekonomi, orang kulit hitam dianggap rendah dan pada jaman dahulu dijadikan budak. Sehingga banyak menimbulkan tekanan batin yang kuat hingga menyebabkan stres timbullah hipertensi. Jika di Indonesia terjadinya hipertensi bervariasi di suatu tempat:

Terendah: Lembah Baliem di Irian Jaya, karena dilihat dari segi geografis wilayahnya masih luas dan penduduknya juga belum terlalu padat sehingga pemicu tingkat stres masih rendah.

Tertinggi: Sukabumi Jawa Barat, karena dilihat dari segi geografis wilayahnya sempit, padat penduduk, dan banyak aktivitas-aktivitas sehingga pemicu tingkat stres sangat tinggi.

3. Urbanisasi

Hal ini akan menyebabkan perkotaan menjadi padat penduduk yang merupakan salah satu pemicu timbulnya hipertensi. Secara otomatis akan banyak kesibukan di wilayah tersebut, dan banyak tersedia makanan- makanan siap saji yang menimbulkan hidup kurang sehat sehingga memicu timbulnya hipertensi.

4. Geografis

Jika dilihat dari segi geografis, daerah pantai lebih besar persentasenya terkena hipertensi. Hal ini disebabkan karena daerah pantai kadar garamnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pegunungan atau daerah yang lebih jauh pantai.

Selain itu keadaan suhu juga menjadi suatu alasan mengapa hipertensi banyak terjadi di daerah pantai

5. Jenis kelamin

Wanita>pria: di usia >50 tahun. Karena di usia tersebut seorang wanita sudah mengalami menopause dan tingkat stres lebih tinggi.

Pria>wanita: di usia <50 tahun. Karena di usia tersebut seorang pria mempunyai lebih banyak aktivitas dibandingkan wanita.

Berdasarkan faktor akibat hipertensi terjadi peningkatan tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara: Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Terjadi penebalan dan kekakuan pada dinding arteri akibat usia lanjut. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini

terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat. Oleh sebab itu, jika aktivitas memompa jantung berkurang, arteri mengalami pelebaran, dan banyak cairan keluar dari sirkulasi, maka tekanan darah akan menurun atau menjadi lebih kecil.

Berdasarkan faktor pemicu, hipertensi dibedakan atas yang tidak dapat dikontrol seperti umur, jenis kelamin, dan keturunan. Pada 70-80% kasus hipertensi primer, didapatkan riwayat hipertensi di dalam keluarga. Apabila

riwayat hipertensi didapatkan pada kedua orang tua, maka dugaan hipertensi primer lebih besar. Hipertensi juga banyak dijumpai pada penderita kembar monozigot (satu telur), apabila salah satunya menderita hipertensi. Dugaan ini menyokong bahwa faktor genetik mempunyai peran di dalam terjadinya hipertensi. Sedangkan yang dapat dikontrol seperti kegemukan/obesitas, stres, kurang olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol dan garam. Faktor lingkungan ini juga berpengaruh terhadap timbulnya

hipertensi esensial. Hubungan antara stres dengan hipertensi, diduga melalui aktivasi saraf simpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas, saraf parasimpatis adalah saraf yang bekerja pada saat kita tidak beraktivitas. Peningkatan aktivitas saraf simpatis dapat meningkatkan tekanan darah secara intermitten (tidak menentu). Apabila stres berkepanjangan, dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi. Walaupun hal ini belum terbukti, akan tetapi angka kejadian di masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengaruh stres yang dialami kelompok masyarakat yang tinggal di kota. Berdasarkan penyelidikan, kegemukan merupakan ciri khas dari populasi hipertensi dan dibuktikan bahwa faktor ini mempunyai kaitan yang erat dengan terjadinya hipertensi di kemudian hari. Walaupun belum dapat dijelaskan hubungan antara obesitas dan hipertensi esensial, tetapi penyelidikan membuktikan bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas dengan hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan penderita yang mempunyai berat badan normal.

E. Manifestasi Klinis Hipertensi

Pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala; meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi (padahal sesungguhnya tidak). Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan dan kelelahan; yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi,

maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala berikut (Alfeus, 2018):

1. sakit kepala
2. Kelelahan
3. Mual
4. Muntah
5. sesak napas
6. Gelisah
7. Pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung dan ginjal.

Kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut ensefalopati hipertensif, yang memerlukan penanganan segera. Penyakit tekanan darah tinggi merupakan kelainan "sepanjang umur", tetapi penderitanya dapat hidup secara normal seperti layaknya orang sehat asalkan mampu mengendalikan tekanan darahnya dengan baik. Di lain pihak, orang yang masih muda dan sehat harus selalu memantau tekanan darahnya, minimal setahun sekali. Apalagi bagi mereka yang mempunyai faktor-faktor pencetus hipertensi seperti kelebihan berat badan, penderita kencing manis, penderita penyakit jantung, riwayat keluarga ada yang menderita tekanan darah tinggi, ibu hamil minum pil kontrasepsi, perokok dan orang yang pernah dinyatakan tekanan darahnya sedikit tinggi. Hal ini dilakukan karena bila hipertensi diketahui lebih dini, pengendaliannya dapat segera dilakukan.

F. Faktor Resiko Hipertensi

Faktor usia sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena dengan bertambahnya umur, maka semakin tinggi mendapat risiko hipertensi. Insiden hipertensi makin meningkat dengan meningkatnya usia. Ini sering disebabkan oleh perubahan alamiah di dalam tubuh yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah dan hormon. Hipertensi pada yang berusia kurang dari 35 tahun akan menaikkan

insiden penyakit arteri koroner dan kematian prematur. Jenis kelamin juga sangat erat kaitannya terhadap terjadinya hipertensi dimana pada masa muda dan paruh baya lebih tinggi penyakit hipertensi pada laki-laki dan pada wanita lebih tinggi setelah umur 55 tahun, ketika seorang wanita mengalami menopause (Depkes, 2010).

Riwayat keluarga juga merupakan masalah yang memicu masalah terjadinya hipertensi. Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. Jika seorang dari orang tua kita memiliki riwayat hipertensi, maka sepanjang hidup kita memiliki kemungkinan 25% terkena hipertensi. Garam dapur merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam patogenesis hipertensi. Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan garam yang minimal. Asupan garam kurang dari 3 gram tiap hari menyebabkan hipertensi yang rendah jika asupan garam antara 5-15 gram per hari, prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20%. Pengaruh asupan garam terhadap timbulnya hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah. Garam mengandung 40% sodium dan 60% klorida. Orang-orang peka sodium lebih mudah meningkat sodium, yang menimbulkan retensi cairan dan peningkatan tekanan darah. Garam berhubungan erat dengan terjadinya tekanan darah tinggi gangguan pembuluh darah ini hampir tidak ditemui pada suku pedalaman yang asupan garamnya rendah. Jika asupan garam kurang dari 3 gram sehari prevalensi hipertensi persentasinya rendah, tetapi jika asupan garam 5-15 gram per hari, akan meningkat prevalensinya 15-20%. Garam mempunyai sifat menahan air. Mengonsumsi garam lebih atau makan-makanan yang diasinkan dengan sendirinya akan menaikkan tekanan darah. Hindari pemakaian garam yang berlebih atau makanan yang diasinkan. Hal ini tidak berarti menghentikan pemakaian garam sama sekali dalam makanan. Sebaliknya jumlah garam yang dikonsumsi batasi (Alfeus, 2018).

Merokok merupakan salah satu faktor yang dapat diubah, adapun hubungan merokok dengan hipertensi adalah nikotin akan menyebabkan peningkatan tekanan darah karena nikotin akan diserap pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan

diedarkan oleh pembuluh darah hingga ke otak, otak akan bereaksi terhadap nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih tinggi. Selain itu, karbonmonoksida dalam asap rokok menggantikan oksigen dalam darah. Hal ini akan mengakibatkan tekanan darah karena jantung dipaksa memompa untuk memasukkan oksigen yang cukup ke dalam organ dan jaringan tubuh. Aktivitas sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi, dimana pada orang yang kurang aktivitas akan cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantung akan harus bekerja lebih keras pada tiap kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung memompa, maka makin besar tekanan yang dibebankan pada arteri. Stres juga sangat erat merupakan masalah yang memicu terjadinya hipertensi dimana hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis peningkatan saraf dapat menaikkan tekanan darah secara intermiten (tidak menentu). Stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi. Walaupun hal ini belum terbukti akan tetapi angka kejadian di masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengaruh stres yang dialami kelompok masyarakat yang tinggal di kota (Alfeus, 2018).

G. Patofisiologi Hipertensi

Masih banyak ketidakpastian tentang patofisiologi hipertensi. Sejumlah kecil pasien (antara 2% dan 5%) memiliki penyakit ginjal atau adrenal yang mendasari sebagai penyebab tekanan darah mengangkat mereka. Namun demikian, dalam sisanya, tidak ada satu pun penyebab jelas yang dapat diidentifikasi dan kondisi mereka diberi label "hipertensi esensial". Sejumlah mekanisme fisiologis yang terlibat dalam pemeliharaan tekanan darah normal, dan gangguan mereka mungkin memainkan bagian dalam pengembangan hipertensi esensial. Sangat mungkin bahwa banyak faktor saling terkait berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi

pada pasien hipertensi, dan peran relatif mereka mungkin berbeda antara individu. Di antara faktor yang telah dipelajari secara intensif adalah asupan garam, obesitas dan resistensi insulin, sistem renin-angiotensin, dan sistem saraf simpatik. Dalam beberapa tahun terakhir, faktor lain telah dievaluasi, termasuk genetika, disfungsi endotel (seperti yang dinyatakan oleh perubahan dalam endotelin dan oksida nitrat), berat lahir rendah dan nutrisi intrauterin, dan anomali neurovaskular. Regulasi tekanan darah normal merupakan proses kompleks. Tekanan darah arterial merupakan produk dari curah jantung dan resistensi vaskular perifer. Curah jantung dipengaruhi oleh asupan garam, fungsi ginjal dan hormon mineralokortikoid, sedangkan efek inotropik timbul dari peningkatan volume cairan ekstraselular dan peningkatan denyut jantung serta kontraktilitas.

Resistensi vaskular perifer bergantung pada sistem saraf simpatis, faktor humoral dan autoregulasi lokal. Sistem saraf simpatis bekerja melalui efek vasokonstriktor alfa atau vasodilator beta. Faktor humoral dipengaruhi oleh berbagai mediator vasokonstriktor (seperti angiotensin dan katekolamin) atau mediator vasodilator (seperti prostaglandin dan kinin). Viskositas darah, kecepatan dan tegangan geser (shear stress) dinding vaskular, kecepatan aliran darah (komponen rerata dan pulsasi) memiliki hubungan dengan regulasi tekanan darah pada vaskular dan fungsi endotel. Volume darah sirkulasi diatur dengan pengendalian air dan garam di dalam ginjal, suatu fenomena yang berperan penting pada individu sensitif-garam. Autoregulasi tekanan darah terjadi melalui pengaturan kontraksi dan ekspansi volume intravascular oleh ginjal, juga melalui pengiriman dari cairan transkapiler. Melalui mekanisme tekanan natriuresis, keseimbangan garam dan air tercapai dengan tekanan sistemik tinggi. Interaksi antara curah jantung dan resistensi perifer- autoregulasi untuk mempertahankan suatu tingkat tekanan darah seseorang. Vasoreaktivitas pembuluh darah merupakan fenomena penting dalam mediasi perubahan tekanan darah, dapat dipengaruhi oleh aktivitas faktor vasoaktif, reaktivitas sel otot polos dan perubahan struktur dan kaliber dinding pembuluh darah, terekspresi sebagai rasio lumen: dinding. Endotel vaskular

merupakan organ vital, tempat sintesis berbagai vasodilator dan vasokonstriktor, mengakibatkan pertumbuhan dan remodeling dinding pembuluh darah dan regulasi hemodinamik tekanan darah. Berbagai hormon, vasoaktif humoral dan peptida pengatur atur dan pertumbuhan dihasilkan di dalam endotel vaskular. Mediator- mediator termasuk angiotensin II, bradikinin, endotelin, nitric- oxide, dan beberapa faktor pertumbuhan. Endotelin merupakan vasokonstriktor kuat dan faktor pertumbuhan yang berperan penting pada patogenesis hipertensi. Angiotensin II merupakan vasokonstriktor hasil sintesis dari angiotensin I dengan bantuan angiotensin-converting enzyme (ACE). Nitric-oxide merupakan vasodilator kuat yang memengaruhi autoregulasi lokal dan fungsi organ penting lain (Reinier, 2018).

H. Pemeriksaan Penunjang Hipertensi

Riwayat dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh sangat penting. Retina harus diperiksa dan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengkaji kemungkinan adanya kerusakan organ, seperti ginjal atau jantung, yang dapat disebabkan oleh tingginya tekanan darah. Hipertrofi ventrikel kiri dapat dikaji dengan elektrokardiografi, protein dalam urin dapat dideteksi dengan urinalisa, serta dapat terjadi ketidakmampuan untuk mengkonsentrasi urin dan peningkatan nitrogen urea darah. Pemeriksaan khusus seperti renogram, pielogram intravena, arteriogram renal, pemeriksaan fungsi ginjal terpisah, dan penentuan kadar urin dapat juga dilakukan untuk mengidentifikasi pasien dengan penyakit renovaskuler. Faktor risiko lainnya juga harus dikaji dan dievaluasi (Alfeus, 2018).

Pemeriksaan Penunjang Hipertensi:

1. Hemoglobin/hematokrit: mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan (viskositas) dan dapat mengindikasikan faktor-faktor risiko seperti hipokoagulabilitas, anemia.
2. BUN/kreatinin: memberikan informasi tentang perfusi/fungsi ginjal.

3. Glukosa: hiperglikemia (Diabetes Melitus adalah pencetus hipertensi) dapat diakibatkan oleh peningkatan kadar katekolamin (meningkatkan hipertensi).
4. Kalium serum: hipokalemia dapat mengindikasikan adanya aldosteron (penyebab) atau menjadi efek samping terapi diuretik.
5. Kalsium serum: peningkatan kadar kalsium serum dapat meningkatkan hipertensi.
6. Kolesterol dan trigeliserida serum: peningkatan kadar dapat mengindikasikan pencetus untuk/adanya pembentukan plak ateromatosa (efek kardiofaskuler).
7. Pemeriksaan tiroid: hipertiroidisme dapat mengakibatkan vasokonstriksi dan hipertensi.
8. Kadar aldosteron urin dan serum: untuk menguji aldosteronisme primer (penyebab).
9. Urinalisa: darah, protein dan glukosa mengisyaratkan disfungsi ginjal dan atau adanya diabetes.
10. VMA urin (metabolit katekolamin): kenaikan dapat mengindikasikan adanya feokromositoma (penyebab); VMA urin 24 jam dapat digunakan untuk pengkajian feokromositoma bila hipertensi hilang timbul.
11. Asam urat: hiperurisemia telah menjadi implikasi sebagai faktor risiko terjadinya hipertensi.
12. Steroid urin: kenaikan dapat mengindikasikan hiperadrenalisme, feokromositoma atau disfungsi pituitari, sindrom Cushing's; kadar renin dapat juga meningkat.
13. IVP: dapat mengidentifikasi penyebab hipertensi, seperti penyakit parenkim ginjal, batu ginjal dan ureter.
14. Foto dada: dapat menunjukkan obstruksi kalsifikasi pada area katub; deposit pada dan/EKG atau takik aorta; perbesaran jantung.
15. CT scan: mengkaji tumor serebral, CSV, ensefalopati, atau feokromositoma.
16. EKG: dapat menunjukkan perbesaran jantung, pola regangan, gangguan konduksi. Catatan: luas, peninggian gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi.

I. Penatalaksanaan Hipertensi

1. Farmakologis

Obat Hipertensi lini pertama yang efektif (Cici, 2018):

a. Diuretik tiazid

Merupakan obat lini pertama yang paling baik dalam mengurangi stroke dan kematian. Mekanismenya dengan mengurangi volume ekstra seluler dan curah jantung.

b. Beta blocker

Obat ini menurunkan irama jantung dan curah jantung. Selain itu, juga menurunkan pelepasan renin dan lebih efektif pada pasien dengan aktivitas renin plasma yang meningkat.

c. ACE-Inhibitor

Sering digunakan pada Hipertensi ringan dan sedang. Cara kerja utamanya ialah menghambat sistem renin-angiotensin-aldosteron, menghambat degradasi bradikinin, menstimulasi sintesis prostaglandin vasodilating, dan kadang-kadang mereduksi aktivitas saraf simpatis.

d. Calcium antagonist long-acting

Calcium antagonist mengakibatkan relaksasi otot jantung dan otot polos, dengan demikian mengurangi masuknya kalsium ke dalam sel. Obat ini mengakibatkan vasodilatasi perifer, dan refleks takikardia dan retensi cairan kurang bila dibanding dengan vasodilator lainnya.

2. Non Farmakologis

a. Mengurangi konsumsi garam

Pembatasan konsumsi garam sangat dianjurkan, maksimal 2 gram dapur untuk diet setiap hari.

b. Olahraga teratur

Menurut penelitian, olahraga secara teratur dapat menyerap atau menghilangkan endapan kolesterol dan pembuluh nadi. Olahraga yang dimaksud adalah latihan menggerakkan semua sendi dan otot tubuh (latihan

isotonik atau dinamik), seperti gerak jalan, berenang, naik sepeda. Tidak dianjurkan melakukan olahraga yang menegangkan seperti tinju, gulat, atau angkat besi, karena latihan yang berat bahkan dapat menimbulkan hipertensi. (Triyanto, 2014).

c. Makan banyak buah dan sayuran segar

Buah dan sayuran segar mengandung banyak vitamin dan mineral. Buah yang banyak mengandung mineral kalium dapat membantu menurunkan tekanan darah.

d. Tidak merokok dan minum alkohol

e. Latihan relaksasi atau meditasi

Relaksasi atau meditasi berguna untuk mengurangi stres atau ketegangan jiwa. Relaksasi dilaksanakan dengan mengencangkan dan mengendorkan otot tubuh sambil membayangkan sesuatu yang damai, indah, dan menyenangkan. Relaksasi dapat pula dilakukan dengan mendengarkan musik, atau bernyanyi (Triyanto, 2014)

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, wearing glasses and a light-colored shirt, is seated at a desk with his hands clasped, looking towards the woman. The woman, wearing a hijab and a white long-sleeved shirt, is also seated at the desk, smiling and looking at the man. A laptop is open in front of her. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text, and a bookshelf with various books.

BAB 2

KONSEP STRESS

A. Pendahuluan

Faktor risiko penting yang memengaruhi timbulnya dan progresivitas hipertensi adalah stres psikologis. Stres dapat memicu aktivasi sistem saraf simpatis dan sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA axis), yang berdampak pada peningkatan kadar kortisol, denyut jantung, dan vasokonstriksi sehingga menimbulkan peningkatan tekanan darah (Liu et al., 2022; Cohen et al., 2021). Paparan stres kronis yang berkelanjutan dapat mengakibatkan disregulasi fisiologis yang berkontribusi terhadap hipertensi jangka panjang (Spruill, 2019).

Selain mekanisme biologis, faktor perilaku juga berperan. Individu yang mengalami stres cenderung memiliki gaya hidup kurang sehat, seperti konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, kurang aktivitas fisik, serta penggunaan alkohol dan rokok, yang semakin memperburuk risiko hipertensi (Trudel-Fitzgerald et al., 2021). Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara stres dan hipertensi penting tidak hanya untuk aspek preventif tetapi juga dalam manajemen terapi yang lebih komprehensif.

B. Pengertian

Menurut Hans Selye, stres adalah semua respon manusia yang bersifat nonspesifik terhadap setiap tuntutan kebutuhan yang ada dalam dirinya. Menurut Dadang Hawari, menyebutkan stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial (tekanan mental atau beban kehidupan).

Menurut Soeharto Heerdjan, stres adalah suatu kekuatan yang mendesak atau mencekam, yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang. Jadi yang

dimaksud stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang dapat menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi, dan sebagainya (Hartono, 2016).

C. Sumber Stress

Sumber stres juga dapat dibedakan dalam lima kategori berdasarkan teori Wheaton dan Montazer dalam (hendro, 2022)

1. Life events

Hal ini menggambarkan peristiwa hidup ataupun perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang. Beberapa contohnya adalah kematian pasangan, perceraian, dan kehilangan pekerjaan (pensiun).

2. Chronic stressor

Sumber stres yang kronis berkembang secara perlahan yang muncul sebagai keberlanjutan dari permasalahan yang terkait dengan peran sosial dan lingkungan sosial. Sumber stres kronis bisa muncul tanpa atau dengan suatu peristiwa yang menyertai. Selain itu pada sumber stres kronis terjadi dalam durasi yang lebih lama dari stresor karena peristiwa hidup yang mencakup masalah dalam keseharian, meski juga dapat terkait dengan stresor lingkungan seperti masalah keuangan dan situasi tempat tinggal.

3. Daily stressor

Sumber stres sehari-hari berbeda dengan sumber stres kronis, kedua stresor ini dibedakan berdasarkan durasi dan tingkat keparahan yang dihasilkan. Stres sehari-hari biasanya terjadi dalam waktu yang singkat, contohnya saat mengalami pertengkaran dengan pasangan atau terjebak macet saat hendak ke kantor.

D. Tingkatan Stress

1. Stres Ringan

Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi stres ringan

berlangsung beberapa menit atau jam saja. Ciri-ciri stres ringan yaitu semangat meningkat, penglihatan tajam, energi meningkat namun cadangan energinya menurun, kemampuan menyelesaikan pelajaran meningkat, sering merasa letih tanpa sebab, kadang - kadang terdapat gangguan sistem seperti pencernaan, otak, perasaan tidak santai. Stres ringan berguna karena dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih tangguh menghadapi tantangan hidup.

2. Stres Sedang

Stres sedang yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri-ciri stres sedang yaitu sakit perut, mules, otot-otot terasa tegang, perasaan tegang, gangguan tidur, dan badan terasa ringan.

3. Stres Berat

Situasi Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan, seperti perselisihan perkawinan secara terus menerus, kesulitan finansial yang berlangsung lama karena tidak ada perbaikan, berpisah dengan keluarga, berpindah tempat tinggal mempunyai penyakit kronis dan termasuk perubahan fisik, psikologis sosial pada usia lanjut. Ciri-ciri stres berat yaitu sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, sulit tidur, negatifistic, penurunan konsentrasi, takut tidak jelas, kelelahan meningkat, tidak mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan gangguan sistem meningkatkan perasaan takut meningkat. (Martini, 2022)

E. Indikator Stress

Indikator stres menurut Cohen sebagai berikut:

1. Perasaan yang tidak terprediksi (feeling of unpredictable).

Stres dalam bentuk ketidakberdayaan dan keputusan muncul Ketika seseorang tidak mampu memprediksi suatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, seperti bencana alam, meninggalnya orang yang dicintai (Cohen, 2013).

2. Perasaan yang tidak terkontrol (feeling of uncontrollable).

Perasaan yang dialami Ketika seseorang tidak mampu mengontrol berbagai peristiwa yang terjadi sehingga akan memberikan efek terhadap munculnya kondisi stres (Cohen, 2013).

3. Perasaan tertekan (feeling of overladed).

Perasaan tertekan ditandai dengan beberapa gejala seperti perasaan benci, sedih, harga diri rendah, cemas, dan gejala psikosomatis lainnya. Seseorang akan cenderung mengalami berbagai perasaan tertekan tersebut ketika mengalami stres (Cohen, 2013).

F. Respon Tubuh Terhadap Stress

Model stres yang diperkenalkan adalah GAS atau General Adaptation Syndrome merupakan gambaran fisiologis tubuh ketika mengalami stres berkepanjangan. GAS terdiri dari tiga fase yaitu:

1. Fase Alarm

Fase ini ditandai dengan kondisi seseorang yang merasakan adanya ancaman dan menunjukkan reaksi flight-flight response. Aktivitas sistem saraf simpatis menghasilkan peningkatan denyut nadi, tekanan darah, pernapasan. Perubahan ini meningkatkan fokus dan energi yang tersedia kepada otot dalam waktu jangka pendek. Pada fase ini terjadi pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin (hendro, 2022).

2. Fase Resistance

Tubuh mulai beradaptasi dengan kehadiran stres dan respon tubuh mulai normal. Tubuh terus mencoba untuk mempertahankan kondisi homeostasis yaitu upaya tubuh untuk mempertahankan kondisi keseimbangan meski dalam kondisi menghadapi tantangan. Kondisi stres yang dapat diatasi akan membuat fase ini berakhir namun ketika stres masih terus dirasakan, tubuh terus berupaya menyesuaikan tingkat stres. Pada kondisi jangka panjang, tubuh tidak dapat terus

menerus menyesuaikan stres yang dirasakan sehingga berlanjut ke fase berikutnya (hendro, 2022).

3. Fase Exhaustion

Fase ini hasil dari stres berkepanjangan yang menyebabkan penurunan sumber daya fisik, emosional dan mental. Fase ini menandakan mekanisme koping tidak lagi bekerja dan menyebabkan penurunan respon tubuh sehingga tidak mampu menghadapi stres. Fase exhaustion paling sering terjadi pada individu yang terpapar stres kronis atau berat (hendro, 2022).

G. Alat Ukur Tingkat Stress

PSS -10 (Perceived Stress Scale) kuisioner ini dibuat untuk mengetahui tentang perasaan dan pikiran yang anda alami dalam satu bulan terakhir.

Pilihan pengisian menggunakan skala likert yaitu:

- 0 (Tidak pernah): Jika merasa bahwa pernyataan tersebut tidak pernah mencerminkan pengalaman anda dalam beberapa minggu terakhir.
- 1 (Jarang): Jika merasa bahwa pernyataan tersebut jarang (1-2 kali)
- 2 (kadang-kadang): Jika merasa bahwa pernyataan tersebut kadang-kadang (3-4 kali) mencerminkan pengalaman anda dalam beberapa minggu terakhir.
- 3 (Hampir Sering): Jika merasa bahwa pernyataan tersebut Hampir sering (5-6 kali) mencerminkan pengalaman anda dalam beberapa minggu terakhir.
- 4 (Sangat Sering): Jika merasa bahwa pernyataan tersebut sangat sering (< 6 kali) mencerminkan pengalaman anda dalam beberapa minggu terakhir.

Jumlah skor tertinggi dalam kuisioner ini yaitu 40 dan skor terendahnya yaitu 0 yang terdiri dari 10 pertanyaan. Setelah mendapatkan skor total, lihatlah interpretasi berikut ini terdiri dari 10 pertanyaan:

1. Skor 0-13: Tingkat stres ringan.
2. Skor 14-26: Tingkat stres sedang.
3. Skor 27-40: Tingkat stres Berat (Jannah,2019).

BAB 3

KONSEP TEKanan DARAH

A. Pendahuluan

Tekanan darah sendiri merupakan hasil dari curah jantung dan resistensi perifer total, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup (Whelton et al., 2018). Ketika tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg berdasarkan pengukuran berulang, kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai hipertensi (Williams et al., 2018).

Peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan organ target seperti jantung, otak, ginjal, dan pembuluh darah. Hipertensi menjadi faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, serta penyakit ginjal kronis (Mills et al., 2020). Data dari World Health Organization (2021) menunjukkan bahwa sekitar 1,28 miliar orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi, namun hampir separuhnya tidak menyadari kondisi yang dialaminya.

Pengendalian tekanan darah merupakan kunci utama dalam pencegahan komplikasi hipertensi. Intervensi mencakup perubahan gaya hidup sehat seperti pembatasan asupan garam, peningkatan aktivitas fisik, manajemen stres, serta terapi farmakologis sesuai indikasi klinis (Carey et al., 2019). Dengan demikian, pemahaman mengenai mekanisme regulasi tekanan darah, faktor risiko, serta strategi pengendaliannya sangat penting untuk menekan dampak hipertensi terhadap kesehatan masyarakat.

B. Pengertian

Tekanan darah adalah besar tekanan yang dihasilkan oleh darah saat mengalir melalui arteri (Kozier, 2011). Tekanan darah pada lansia mengalami peningkatan saat katup jantung menebal dan menjadi kaku menyebabkan pembuluh darah kehilangan elastisitas, resistensi perifer meningkat karena kehilangan elastisitas pembuluh darah dan volume darah menurun (Nugroho, 2017).

C. Jenis Tekanan Darah

Jenis tekanan darah menurut Kozier, 2011 adalah:

1. Tekanan sistolik

Tekanan sistolik adalah tekanan darah yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel, yaitu tekanan pada puncak gelombang darah.

2. Tekanan Diastolik

Tekanan Diastolik adalah tekanan ventrikel pada saat istirahat dan tekanan yang lebih rendah, akan selalu ada dalam arteri

3. Tekanan Nadi

Tekanan nadi merupakan selisih antara tekanan sistolik dan diastolik.

D. Fisiologi Tekanan Darah

1. Curah Jantung

Ketika kerja curah jantung melemah, sedikit darah yang di pompa oleh jantung ke arteri (penurunan) dan terjadi penurunan tekanan darah. Ketika kerja pompa jantung menguat dan volume darah yang di pompa ke dalam sirkulasi meningkat (peningkatan curah jantung) terjadi peningkatan tekanan darah (Kozier, 2011).

2. Vaskular Perifer

Tahanan vascular perifer dapat meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah yang paling terpengaruh adalah tekanan diastolik. Beberapa faktor yang menimbulkan tahanan pada sistem arteri antara lain kapasitas arteriol dan kapiler,

komplians arteri, dan viskositas darah. Diameter internal atau kapasitas arteriolar dan kapiler sangat menentukan besar tahanan perifer terhadap darah dalam tubuh. Semakin kecil ruang di dalam pembuluh darah, semakin besar tahanan yang dihasilkan normalnya, arteriolar berkonstriksi sebagian. Peningkatan vasokonstriksi akan meningkatkan tekanan darah, sedangkan penurunan vasokonstriksi akan menurunkan tekanan darah. Apabila jaringan elastis dan jaringan otot dalam arteri digantikan dengan jaringan fibrosa, arteri akan kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk mengerut dan mengembang. Kondisi ini, yang paling sering ditemui pada dewasa menengah dan lansia, disebut sebagai arteriosklerosis (Kozier, 2011)

3. Volume Darah

Ketika terjadi penurunan volume darah (misalnya akibat hemoragi atau dehidrasi), tekanan darah akan menurun akibat berkurangnya jumlah cairan dalam arteri. Sebaliknya, ketika terjadi peningkatan volume darah (misalnya akibat pemberian cairan intravena yang sangat cepat), tekanan darah akan meningkat karena terdapat darah dalam jumlah besar dalam sistem sirkulasi (Kozier, 2011).

4. Viskositas Darah

Tekanan darah akan meningkat apabila darah sangat kental, yaitu ketika perbandingan antara sel darah dan plasma darah meningkat. Perbandingan ini disebut dengan hematokrit. Viskositas darah akan meningkat secara bermakna ketika hematokrit lebih dari 60%-65% (Kozier, 2011).

5. Elastisitas

Normalnya dinding darah arteri elastis dan mudah berdistensi. Jika tekanan dalam arteri meningkat, diameter dinding pembuluh meningkat untuk mengakomodasi perubahan tekanan. Elastisitas arteri turun tahanan vaskular perifer meningkat. Pengontrolan yang kompleks dari sistem kardiovaskular secara normal mencegah salah satu faktor secara permanen mengubah tekanan darah (Potter, 2005)

E. Faktor Mempengaruhi Tekanan Darah

Faktor mempengaruhi Tekanan Darah menurut Kozier, 2011.

1. Usia

Bayi baru lahir memiliki tekanan sistolik rata-rata sekitar 75 mmHg. Tekanan tersebut meningkat seiring dengan usia, mencapai puncaknya pada pubertas, dan kemudian cenderung sedikit menurun pada lansia, elastisitas arteri mengalami penurunan arteri lebih kaku, resistensi pembuluh darah perifer meningkat dan kurang mampu meredakan tekanan darah. Karena dinding pembuluh darah tidak mampu berelastisitas (kembali ke posisi semula) dengan kelenturan yang sama saat terjadi penurunan tekanan, tekanan diastolik juga akan meningkat (Kozier, 2011)

2. Olahraga

Aktivitas fisik akan meningkatkan curah Jantung dan kemudian meningkatkan tekanan darah dengan demikian, individu perlu beristirahat selama 20-30 menit setelah berolahraga sebelum tekanan darah pada kondisi istirahat dapat dikaji secara konsisten (Kozier, 2011).

3. Stres

Stimulasi sistem saraf simpatik meningkatkan curah jantung dan vasokonstriksi arteriol, yang kemudian akan meningkatkan tekanan darah, Salah satu respon terhadap stres adalah respon fisiologis yang terjadi saat seseorang menunjukkan reaksi flight fight response. Aktivitas sistem saraf simpatik pada saat terjadi reaksi tersebut menghasilkan peningkatan tekanan darah. Pada fase ini terjadi pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin (hendro, 2022).

Dimensi stres menurut Cohen sebagai berikut:

- a. Perasaan yang tidak terprediksi (feeling of unpredictable). Stres dalam bentuk ketidakberdayaan dan keputusan muncul Ketika seseorang tidak mampu memprediksi suatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, seperti bencana alam, meninggalnya orang yang dicintai (Cohen, 2013).
- b. Perasaan yang tidak terkontrol (feeling of uncontrollable). Perasaan yang dialami Ketika seseorang tidak mampu mengontrol berbagai peristiwa yang

terjadi sehingga akan memberikan efek terhadap munculnya kondisi stress (Cohen, 2013).

- c. Perasaan tertekan (feeling of overladed). Perasaan tertekan ditandai dengan beberapa gejala seperti perasaan benci, sedih, harga diri rendah, cemas, dan gejala psikosomatis lainnya. Seorang akan cenderung mengalami berbagai perasaan tertekan tersebut Ketika mengalami stres (Cohen, 2013).

4. Ras

Pria Amerika-Afrika yang berusia di atas 35 tahun memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dari pada pria Eropa-Amerika pada usia yang sama.

5. Jenis kelamin

Setelah pubertas, wanita biasanya memiliki tekanan darah yang lebih rendah daripada pria pada usia yang sama, perbedaan ini diduga terkait dengan variasi hormon. Setelah menopause, wanita umumnya memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

6. Medikasi

Beberapa obat dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan darah.

7. Obesitas

Obesitas pada masa kanak-kanak maupun masa dewasa lansia dapat mempredisposisi hipertensi.

8. Variasi Diurnal

Tekanan darah biasanya berada pada titik terendah pada pagi hari, yakni ketika laju metabolisme berada pada titik paling rendah, kemudian meningkat sepanjang hari dan mencapai titik puncak pada sore hari atau menjelang malam.

9. Proses Penyakit

Setiap kondisi yang memengaruhi curah jantung, volume darah, viskositas darah, dan stan COMPLIANS arteri akan berdampak langsung pada tekanan darah.

F. Faktor Mempengaruhi Tekanan Darah

1. Tekanan Darah Rendah

Tekanan Darah Rendah adalah tekanan darah yang berada di bawah nilai normal, artinya, tekanan sistolik terus-menerus berada di antara nilai $\leq 90/60$ (Potter, 2005). Pada Hipotensi juga dapat disebabkan oleh penggunaan obat analgesic seperti meperidin hidroklorida (Damerol), perdarahan, luka bakar serius, dan dehidrasi. Penting untuk mengawasi klien yang mengalami hipotensi secara ketat untuk mencegah terjatuh (Kozier, 2011)

2. Tekanan Darah Normal

Tekanan darah normal adalah sesuai dan tidak menyimpang dari keadaan tanpa cacat dan tidak ada kelainan. Tekanan darah normal pada lansia adalah sistolik 91-139 / diastolik 61-90 mmHg (Brunner, 2013)

3. Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah yang terus-menerus berada di atas nilai normal disebut hipertensi (Kozier, 2011). Tekanan darah tinggi pada lansia Ketika mencapai 140 /90 mmHg (Kemenkes, 2021). Pada lansia juga sering mengalami hipertensi sistolik terisolasi yaitu keadaan dimana tekanan darah sistolik tinggi dan tekanan darah diastolik menurun ≥ 140 dan ≥ 90 .

G. Upaya Agar Tekanan Darah Terkontrol

1. Pengontrolan berat badan

Penurunan berat badan adalah perubahan gaya hidup yang paling besar pengaruhnya terhadap perbaikan tekanan darah (Kowalski dalam Hutagulung, 2019).

2. Menghindari alkohol

Pemakaian alkohol berlebihan akan menyebabkan peningkatan tekanan darah yang dapat meningkatkan terjadinya stroke (Lewis dalam Hutagulung, 2019).

3. Mengurangi stres

Stres dapat meningkatkan tekanan darah dalam jangka waktu yang singkat (Lewis dalam Hutagulung, 2019), oleh sebab itu, penderita hipertensi dianjurkan untuk hidup rileks dan menghindari stres (Martuti dalam Hutagulung, 2019). Agar hidup lebih santai dan tidak emosional, ajaklah lansia sesekali untuk berekreasi, menciptakan suasana rumah yang damai dan penuh kekeluargaan, serta hindarkan suasana yang dapat membangkitkan emosi (Martuti dalam Hutagulung, 2019). Dapat disimpulkan bahwa dengan menghindari stres dapat terhindar dari peningkatan tekanan darah (Hutagulung, 2019).

4. Mencegah dehidrasi dan perdarahan

Saat terjadinya dehidrasi atau perdarahan akan terjadi penurunan volume darah mengakibatkan tekanan darah menurun akibat berkurangnya jumlah cairan dalam arteri (Kozier, 2011).

5. Mengawasi klien dengan hipotensi ortostatik.

Perlunya mengawasi klien yang mengalami hipotensi ortostatik untuk mencegah terjadinya jatuh karena terjadi penurunan tekanan darah ketika klien duduk atau berdiri (Kozier, 2011).

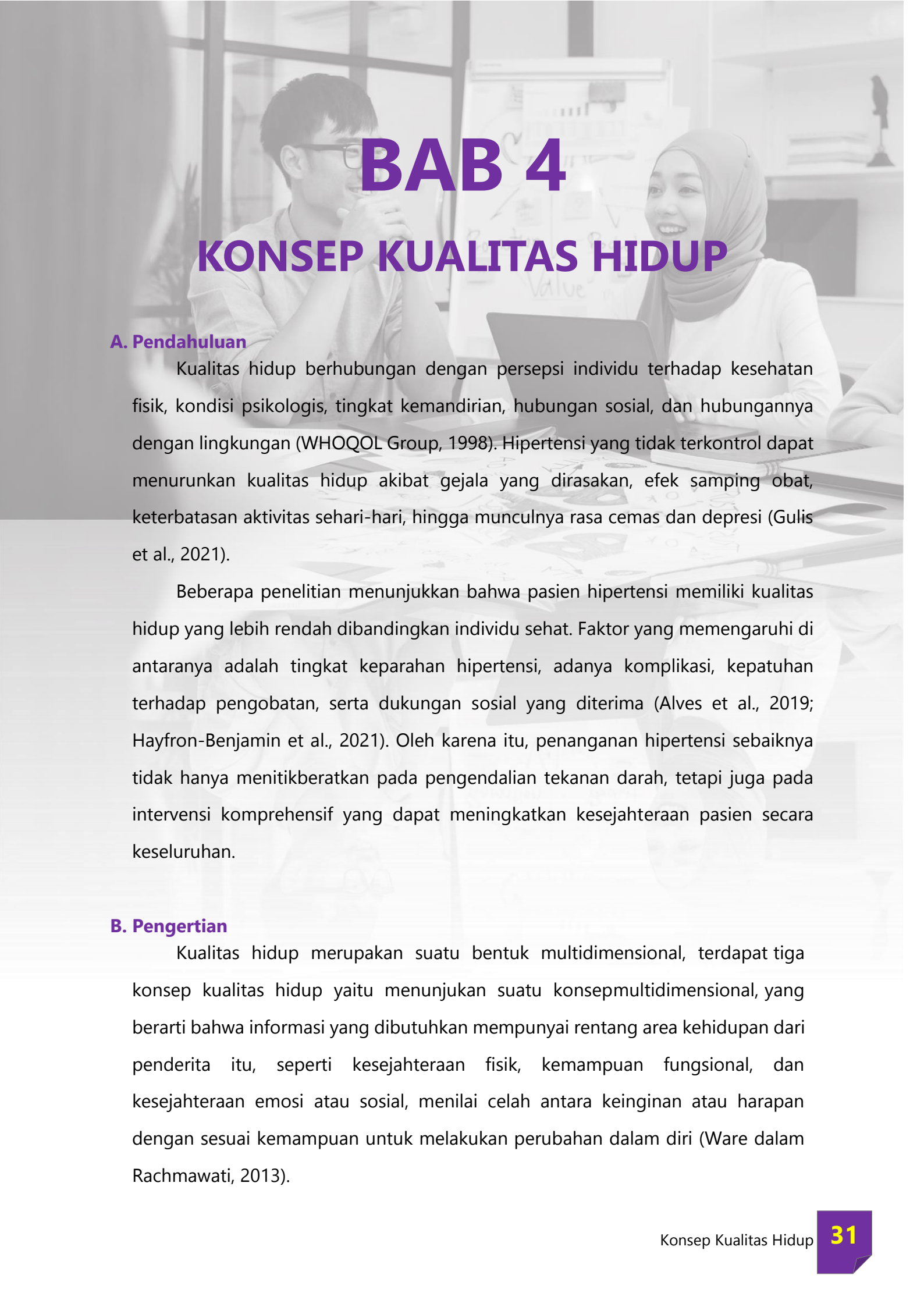
6. Mengecek Tekanan darah secara rutin

Keluarga harus mengingatkan lansia untuk selalu memeriksakan tekanan darahnya minimal 1 bulan sekali ke pelayanan kesehatan secara rutin sehingga kondisi kesehatan lansia bisa di kontrol dengan baik (Hutagulung, 2019)

H. Komplikasi Tekanan Darah

Komplikasi yang terjadi yaitu aterosklerosis yaitu pengerasan pada dinding arteri yang terjadi karena terlalu besarnya tekanan, aterosklerosis yaitu penumpukan lemak pada pembuluh darah, aneurisma yaitu terbentuknya gambaran seperti balon pada dinding pembuluh darah akibat melemah atau tidak elastisnya pembuluh darah, penyakit pada arteri koronaria misalnya karena plak, hipertropi bilik kiri jantung akibat ototnya yang bekerja terlalu berat ketika memompakan darah ke

aorta, gagal jantung yaitu suatu keadaan ketika jantung tidak kuat memompa darah ke seluruh tubuh (Hutagulung, 2019).

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, wearing glasses, is on the left, looking towards the woman. The woman, wearing a hijab, is on the right, smiling and looking at a laptop. They appear to be in a meeting or collaborative work environment. The title 'BAB 4 KONSEP KUALITAS HIDUP' is overlaid in large purple letters.

BAB 4

KONSEP KUALITAS HIDUP

A. Pendahuluan

Kualitas hidup berhubungan dengan persepsi individu terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, dan hubungannya dengan lingkungan (WHOQOL Group, 1998). Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas hidup akibat gejala yang dirasakan, efek samping obat, keterbatasan aktivitas sehari-hari, hingga munculnya rasa cemas dan depresi (Gulis et al., 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien hipertensi memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan individu sehat. Faktor yang memengaruhi di antaranya adalah tingkat keparahan hipertensi, adanya komplikasi, kepatuhan terhadap pengobatan, serta dukungan sosial yang diterima (Alves et al., 2019; Hayfron-Benjamin et al., 2021). Oleh karena itu, penanganan hipertensi sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada pengendalian tekanan darah, tetapi juga pada intervensi komprehensif yang dapat meningkatkan kesejahteraan pasien secara keseluruhan.

B. Pengertian

Kualitas hidup merupakan suatu bentuk multidimensional, terdapat tiga konsep kualitas hidup yaitu menunjukkan suatu konsep multidimensional, yang berarti bahwa informasi yang dibutuhkan mempunyai rentang area kehidupan dari penderita itu, seperti kesejahteraan fisik, kemampuan fungsional, dan kesejahteraan emosi atau sosial, menilai celah antara keinginan atau harapan dengan sesuai kemampuan untuk melakukan perubahan dalam diri (Ware dalam Rachmawati, 2013).

Kualitas hidup merupakan suatu indikator untuk menilai kesejahteraan seseorang atau masyarakat, kualitas hidup bukan hanya melihat dari kekayaan ataupun pekerjaan seseorang melainkan konteks kesehatan serta dapat dilihat dari lingkungan binaan, kesehatan mental dan fisik, rekreasi, pendidikan ataupun waktu luang seseorang (Widagdo, 2015). Menurut *EuroQoL*, terdapat lima dimensi kualitas hidup yaitu kemampuan berjalan, perawatan diri, kegiatan yang biasa dilakukan rasa nyeri/tidak nyaman, rasa cemas/depresi (sedih) (EuroQoL, 2013).

Kualitas hidup lanjut usia merupakan suatu komponen yang kompleks, mencakup usia harapan hidup, kepuasan dalam kehidupan, kesehatan psikologis dan mental, fungsi kognitif, kesehatan dan fungsi fisik, pendapatan, kondisi tempat tinggal, dukungan sosial dan jaringan sosial (Sutikno, 2011).

Berdasarkan definisi kualitas hidup diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup merupakan persepsi atau penilaian subjektif dari individu yang mencakup beberapa aspek sekaligus, yang meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, kognitif, hubungan dengan peran, aspek spiritual dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Kualitas hidup dipengaruhi oleh tingkat kemandirian, kondisi fisik dan psikologis, aktifitas sosial, interaksi sosial dan fungsi keluarga. Pada umumnya lanjut usia mengalami keterbatasan, sehingga kualitas hidup pada lanjut usia menjadi mengalami penurunan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan lanjut usia untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia (Yuliati, 2014).

Pada umumnya lanjut usia mengalami keterbatasan, sehingga kualitas hidup pada lanjut usia menjadi mengalami penurunan. Agar kualitas hidup lansia meningkat, maka dalam penyesuaian diri dan penerimaan segala perubahan yang dialami, lansia harus mampu melakukan tersebut. Selain itu, lingkungan yang memahami kebutuhan dan kondisi psikologis lansia membuat lansia merasa dihargai. Tersedianya media atau sarana bagi lansia membuat lansia dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

C. Jenis-Jenis Kualitas Hidup

Menurut WHOQoL-BREF (Power dalam Lopez & Snyder, 2013) terdapat empat jenis-jenis mengenai kualitas hidup yang meliputi:

1. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke tahap selanjutnya. Kesehatan fisik mencakup aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat-obatan, energi dan kelelahan, mobilitas, sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, kapasitas kerja. Hal ini terkait dengan *private self consciousness* yaitu mengarahkan tingkah laku ke perilaku *covert*, dimana individu lain tidak dapat melihat apa yang dirasakan dan dipikirkan individu secara subjektif.

2. Psikologis

Terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan mental mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Aspek psikologis juga terkait dengan aspek fisik, dimana individu dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik bila individu tersebut sehat secara mental. Kesejahteraan psikologis mencakup *bodily image* dan *appearance*, perasaan positif, perasaan negatif, *self esteem*, keyakinan pribadi, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi, penampilan dan gambaran jasmani. Apabila dihubungkan dengan *private self consciousness* adalah individu merasakan sesuatu apa yang ada dalam dirinya tanpa ada orang lain mengetahuinya, misalnya memikirkan apa yang kurang dalam dirinya saat berpenampilan.

3. Hubungan Sosial

Hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Mengingat manusia adalah makhluk sosial maka dalam hubungan sosial ini, manusia dapat merealisasikan kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya. Hubungan sosial mencakup relasi personal, dukungan sosial; aktivitas seksual. Hubungan sosial terkait akan *public self consciousness* yaitu bagaimana individu dapat berkomunikasi dengan orang lain.

4. Lingkungan

Tempat tinggal individu, termasuk di dalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah saran dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan mencakup sumber finansial, kebebasan, keamanan dan keselamatan fisik, perawatan kesehatan dan sosial termasuk aksesibilitas dan kualitas; lingkungan rumah, kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi baru maupun ketrampilan; partisipasi dan mendapat kesempatan untuk melakukan rekreasi dan kegiatan yang menyenangkan di waktu luang; lingkungan fisik termasuk polusi, kebisingan, lalu lintas, iklim; serta transportasi. Berfokus pada *public self consciousness* dimana individu memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup menurut *Moons, Marquet, Budst, & de Geest* (Salsabila, 2012) dalam konseptualisasi yang dikemukakannya, sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Gender adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Adanya perbedaan antara kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, dimana kualitas hidup laki-laki cenderung lebih baik dari pada kualitas hidup

perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan dalam hubungannya dengan kualitas hidup pada laki-laki dan perempuan.

2. Usia

Usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Adanya perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup subjektif. Adanya pengaruh positif dari pendidikan terhadap kualitas hidup subjektif namun tidak banyak.

4. Pekerjaan

Terdapat perbedaan kualitas hidup antara penduduk yang berstatus sebagai pelajar, penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja (atau sedang mencari pekerjaan), dan penduduk yang tidak mampu bekerja (atau memiliki *disability* tertentu). Status pekerjaan berhubungan dengan kualitas hidup baik pada pria maupun wanita.

5. Status

Terdapat perbedaan kualitas hidup antara individu yang tidak menikah, individu bercerai ataupun janda, dan individu yang menikah atau kohabitasi. Pada pria maupun wanita, individu dengan status menikah atau kohabitasi memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi.

6. Penghasilan

Bidang penelitian yang sedang berkembang dan hasil penilaian teknologi kesehatan mengevaluasi manfaat, efektivitas biaya, dan keuntungan bersih dari terapi. Hal ini dilihat dari penilaian perubahan kualitas hidup secara fisik, fungsional, mental, dan kesehatan sosial dalam rangka untuk mengevaluasi biaya

dan manfaat dari program baru dan intervensi.

7. Hubungan dengan orang lain

Saat kebutuhan akan hubungan dekat dengan orang lain terpenuhi, baik melalui hubungan pertemanan yang saling mendukung maupun melalui pernikahan, manusia akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara fisik maupun emosional, bahwa faktor hubungan dengan orang lain memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan kualitas hidup subjektif.

8. Kesehatan fisik

Penyakit *psoriasis* merupakan penyakit kronik residif sehingga berdampak pada kualitas hidup penderita hingga menyebabkan penderita merasa depresi bahkan bunuh diri. *Psoriasis* berdampak negatif sedang hingga berat terhadap kualitas hidup penderita karena terdapat perubahan aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah tonggak penting dalam perkembangan kualitas hidup tentang kepedulian terhadap kesehatan. WHO mendefinisikan kesehatan tidak hanya sebagai sesuatu penyakit tapi dapat dilihat dari fisik, mental dan kesejahteraan sosial.

E. Alat Ukur Kualitas Hidup

Dalam penilaian kualitas hidup ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien yaitu kualitas hidup ini mempunyai beberapa dimensi aspek penilaian. Sudah banyak pengembangan untuk alat ukur kualitas hidup pada pasien penderita kronik, salah satunya adalah WHOQOL-BREF yang mempunyai 26 pertanyaan, tetapi pertanyaan nomor 1 dan 2 tidak dihitung karena merupakan pertanyaan yang umum, terdiri dari 5 skala poin. Dari setiap pertanyaan no 3,4, dan 26 dikarenakan pertanyaan ini mempunyai sifat negatif, maka memiliki jawaban yang dimulai skor 1 = sangat tidak memuaskan sampai skor 5 = sangat memuaskan skor yang didapatkan adalah 0 – 100 akan dimasukkan kedalam rumus (WHO, 1996). Dominan dan aspek dalam WHOQOL-BREF menurut WHO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Domain dan Aspek yang dinilai dalam WHOQOL-BREF

Domain		Aspek yang dinilai
Kesehatan fisik		Nyeri dan tidak nyaman Bergantung pada medis Energi dan kelelahan Mobilitasnya Tidur dan istirahatnya Aktivitas sehari-harinya Kapasitas kerjanya
Kesehatan psikologis		Afek positif Spiritual/agama/kepercayaan Pikiran, belajar, memori, dan konsentrasi <i>Body image</i> dan penampakan Harga dirinya Afek negative
Hubungan sosial		Aktivitas seksualnya Dukungan sosialnya
Lingkungan		Keamanan fisiknya Lingkungan fisik (polusi, suara, lalu lintas, iklim) sumber keuangannya Peluang untuk mendapatkan informasi dan keterampilan Partisipasi dan kesempatan untuk rekreasi/waktu luang Lingkungan rumahnya Perawatan kesehatan dan social; kemampuan akses dan kualitas Transportasinya

Adapun rumus yang dipakai adalah rumus baku yang sudah ditetapkan WHO (2004) sebagai berikut: $TRANSFORMED\ SKOR = (SKOR - 4) \times (100/16)$ Hasil ini dipersentasikan caranya dengan memberi skor dan diinterpretasikan memakai kriteria sebagai berikut:

0-20 = Kualitas Hidup Sangat Buruk

21-40 = Kualitas Hidup Buruk
41-60 = Kualitas Hidup Sedang
61-80 = Kualitas Hidup Baik
81-100 = Kualitas Hidup Sangat Baik

A background image showing a man and a woman in a professional setting, possibly a meeting or a classroom. The man is on the left, wearing glasses and a light-colored shirt, with his hands clasped. The woman is on the right, wearing a hijab and a light-colored top, smiling. They are both looking towards the right. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and a laptop on a table.

BAB 5

KONSEP MINDFULNES TERAPI

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian dalam bidang psikologi klinis dan kesehatan mental semakin tertuju pada pendekatan berbasis *mindfulness*. Salah satu intervensi yang paling menonjol adalah Mindfulness Therapy, yakni terapi psikologis yang berakar pada praktik meditasi dan tradisi Buddhis, tetapi telah diadaptasi ke dalam kerangka ilmiah modern untuk tujuan klinis (Kabat-Zinn, 2003).

Mindfulness Therapy berfokus pada pengembangan *kesadaran penuh* terhadap pengalaman saat ini dengan sikap penerimaan tanpa penilaian (*non-judgmental awareness*). Praktik ini melatih individu untuk menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh secara lebih jernih, sehingga dapat mengurangi kecenderungan bereaksi otomatis terhadap stres atau pikiran negatif (Bishop et al., 2004). Dalam konteks psikoterapi, mindfulness dipandang sebagai strategi transdiagnostik yang efektif untuk berbagai masalah psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, maupun trauma (Hofmann et al., 2010).

Kemunculan Mindfulness Therapy didukung oleh bukti empiris yang semakin luas. Meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi berbasis mindfulness memiliki dampak positif signifikan pada kesehatan mental, khususnya dalam menurunkan gejala kecemasan dan depresi (Khoury et al., 2013). Bahkan, penelitian neuroimaging menemukan bahwa latihan mindfulness berkaitan dengan perubahan struktur dan fungsi otak pada area yang terlibat dalam regulasi emosi, perhatian, dan pemrosesan stres (Hölzel et al., 2011).

Selain itu, Mindfulness Therapy juga telah diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti *Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)*, *Mindfulness-Based Cognitive*

Therapy (MBCT), dan pendekatan integratif lainnya yang dikombinasikan dengan terapi perilaku-kognitif maupun terapi berbasis penerimaan (Baer, 2003). Keberhasilan pendekatan ini menjadikannya salah satu inovasi terpenting dalam psikoterapi kontemporer.

B. Pengertian

Mindfulness sering digambarkan sebagai inti dari meditasi Buddhis yang secara umum tentang perhatian dan kesadaran dimana dua aspek ini adalah kapasitas yang ada dalam diri semua manusia (J Kabat-Zinn, 2016). *Mindfulness therapy* sebagai sebuah strategi pemusatan perhatian guna mengaktifkan pikiran untuk menurunkan gangguan emosional (Dalen et al., 2010). Strategi *mindfulness* ini berupa menghindari gangguan dalam pikiran dan mengendalikan pikiran melalui lima objek dalam pikiran, yaitu pikiran, perasaan, persepsi, ingatan, dan keinginan atau dorongan (Pradhan, 2015).

Mindfulness adalah langkah dimana seseorang mengembangkan kemampuan yang melibatkan lima atribut, yaitu *experience being present* (kemampuan mempertahankan kesadaran dan perhatian) *acceptance* (menerima apa yang sedang terjadi), *attention* (perhatian), *awareness* (kesadaran dalam mengamati arus pikiran), dan *transformative procces* (penegasan arah hidup) (White, 2014).

C. Jenis

Ada dua jenis praktek *mindfulness* yaitu *mindfulness based cognitive therapy* dan *mindfulness based stress reduction* (Stuart, 2013) namun semakin kompleks permasalahan individu maka muncul pengembangan basis dari *mindfulness*, yaitu *mindfulness based intervention* dengan tujuan menumbuhkan kesadaran yang lebih besar dari pengalaman yang saat ini dirasakan (Creswell, 2017). Berikut adalah penjelasan mengenai jenis *mindfulness therapy*

1. *Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)*

Meditasi *mindfulness based stress reduction* ini berguna dalam lingkup berhubungan langsung dan bekerjasama secara konstruktif dengan masalah yang dihadapi, jalan keluar yang berhasil dan tidak berhasil dalam mengatasi masalah tersebut (Stahl et al., 2010). Tujuh pilar utama dari praktik *mindfulness* berbasis *stress reduction* ini yaitu tidak menghakimi, kesabaran, pikiran pemula, kepercayaan, *non-striving*, menerima, dan memulai kembali (Jon Kabat-Zinn & Hanh, 2013).

2. *Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)*

MBCT dikembangkan oleh Segal, Williams, dan Teasdale tahun 2013 yang didasari oleh *mindfulness based stress reduction* dari Kabat-Zinn. MBCT dikembangkan sebagai program psikoedukasi untuk mengajarkan keterampilan kesadaran dan prinsip-prinsip terapi perilaku kognitif dimana di dalamnya termasuk diskusi dan pendidikan tentang depresi, stress, kecemasan, PTSD, dan masalah kesehatan mental lainnya (Sears & Chard, 2016).

3. *Mindfulness Based Intervention (MBI)*

MBI bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang di dalamnya mencakup MBSR atau MBCT tetapi dalam MBI ini ada banyak intervensi lain yang berhubungan dengan kesadaran yang menggabungkan latihan kesadaran sebagai salah satu komponen dari program contohnya *acceptance and commitment therapy*, *dialectical therapy*, *cognitive stress management*, *integrative body-mind training* (Creswell, 2017). MBI ini bermanfaat terhadap kesehatan fisik (misalnya mengurangi nyeri kronik, meningkatkan imunitas, mengurangi gejala klinis dari suatu penyakit dan perilaku lebih sehat) dan berpengaruh terhadap kesehatan mental (misalnya membantu individu yang mengalami depresi, kecemasan, kecanduan bahan adiktif) (Creswell, 2017).

D. Antecedent Mindfulness

Praktik *mindfulness* terdiri dari praktik formal dan informal yang saling berpengaruh satu sama lain. Praktik formal bertujuan mengembangkan aspek perhatian, meningkatkan kewaspadaan dan penerimaan (Day & Horton- Deutch, 2004 dalam Alimuddin, 2018) misalnya bernafas, latihan yoga, meditasi duduk, meditasi berjalan, pemindaian tubuh, dan makan secara sadar sedangkan praktik informal lebih mengarah pada aktivitas sehari-hari dimana klien berupaya menghadirkan kesadaran dalam setiap kegiatannya misalnya saat bersih-bersih rumah, duduk bahkan saat bekerja.

E. Manfaat Mindfulness Therapy

Mindfulness sebagai terapi pemusatan perhatian dengan kesadaran dapat berpengaruh terhadap mekanisme psikologi dan *neurology* (Creswell, 2017) sehingga membuat individu lebih tenang. Hal ini bermanfaat untuk menurunkan stress, *ego depletion*, *burn out*, kecemasan, nyeri (Saripah & Handiyani, 2019; Syafira & Paramastri, 2018; A. P. Wahyudi et al., 2020; Creswell, 2017) bahkan dapat meningkatkan kualitas tidur (Liu et al., 2019).

F. Mekanisme Kerja Mindfulness

Komponen dalam mekanisme kerja *mindfulness* menurut Holzel, et al (2011 dalam Alimuddin, 2018) adalah melibatkan area otak, dimana pasien akan memfokuskan perhatian yang diperankan oleh *Anterior Cingulate Cortex (ACC)* kemudian tubuh akan berespon waspada yang dipengaruhi oleh *Insula temporo parietal junction*. Kondisi waspada akan mengaktifkan regulasi emosi, penilaian diri, keterbukaan dan penguatan yang diperankan oleh (*Dorsal*) *Prefrontal cortex (PFC)* dan *Ventro medial PFC*, *hippocampus* serta *amygdala*. Alur emosi yang telah terbentuk akan berdampak pada perubahan perspektif diri sebagai hasil keterlibatan dari *Medial PFC*, *Posterior Cingulate Cortex (PCC)* *insula*, *temporo-parietal junction*. Komponen ini juga selaras dengan pernyataan bahwa meditasi *mindfulness* dapat

mengaktifkan jaringan daerah otak termasuk insula, putamen (struktur otak tengah, *somato sensory cortex*, bagian dari korteks cingulate anterior dan korteks prefrontal (Tomasino & Fabbro, 2016; Zeidan et al., 2015) serta meningkatkan kepadatan materi abu-abu di bagian hipokampus (Holzel et al., 2011).

Mindfulness juga sebagai penyangga stress dimana latihan ini akan meningkatkan aktivitas dan konektivitas fungsional daerah kortikal prefrontal yang berperan penting dalam regulasi *stress top-down* misalnya amigdala, korteks cingulate anterior subgenual (Creswell et al., 2014). Hölzel et al. (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan *mindfulness* dapat meningkatkan aktivitas prefrontal ventrolateral yang berkaitan dengan pengurangan kecemasan pada pasien dengan gangguan kecemasan umum. *Mindfulness* apabila dikaji dari segi mekanisme psikologi, intervensi ini berfokus pada kesadaran diri, menumbuhkan kemampuan mengamati momen-momen seseorang secara lebih objektif dengan pola pikir yang menyeluruh sehingga tumbuh respon penerimaan dan keterampilan dalam meregulasi emosi (Creswell, 2017).

G. Indikasi dan Kontraindikasi Mindfulness Therapy

Mindfulness therapy dalam praktiknya menggunakan kesadaran yang mana akan menimbulkan kewaspadaan dan kemampuan memusatkan perhatian. Oleh karena itu dalam pelaksanaan terapi ini harus memperhatikan kondisi pasien atau klien terlebih dahulu. Indikasi terapi *mindfulness* biasanya dianjurkan pada mereka yang mengalami kecemasan baik kecemasan umum maupun kecemasan *disorder* (Liu et al., 2019; Sado et al., 2018) nyeri aktual dan /atau kronis (S. Kim et al., 2017; Luiggi-Hernandez et al., 2018) depresi (Zou et al., 2018) *pasien post traumatic stress disorder* (PTSD) (Boyd et al., 2017) dan gangguan-gangguan psikologis lain baik mental *illness* maupun non-mental *illness*. Kontra indikasi dari terapi *mindfulness* ini adalah mereka yang tidak sadar penuh yang mana tidak akan mampu memusatkan perhatian dan kewaspadaan serta mereka yang mengalami gangguan mental organik (Otani et al., 2017)

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, wearing glasses and a light-colored shirt, is seated at a table with his hands clasped, looking towards the woman. The woman, wearing a hijab and a light-colored top, is also seated at the table, looking at the man with a smile. They appear to be in a collaborative meeting or discussion. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and a laptop on the table.

BAB 6

KONSEP MINDFULNES BASED STRESS REDUCATION

A. Pendahuluan

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) merupakan sebuah program intervensi psikologis berbasis meditasi mindfulness yang pertama kali dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn pada akhir 1970-an di University of Massachusetts Medical Center. Tujuan utamanya adalah membantu individu mengelola stres, rasa sakit kronis, serta masalah kesehatan mental dengan meningkatkan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini secara non-reaktif dan tanpa menghakimi (*non-judgmental awareness*) (Kabat-Zinn, 1982).

Seiring perkembangan, MBSR banyak digunakan pada berbagai konteks klinis dan non-klinis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa MBSR mampu menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan psikologis, serta regulasi emosi (Grossman et al., 2004; Khoury et al., 2015). Meta-analisis terbaru juga menegaskan bahwa MBSR efektif sebagai intervensi komplementer dalam bidang kesehatan mental dan fisik, termasuk pada pasien dengan penyakit kronis seperti kanker, penyakit kardiovaskular, serta gangguan nyeri (Goldberg et al., 2018; Hilton et al., 2017).

Selain itu, penerapan MBSR semakin meluas ke populasi umum, lingkungan kerja, hingga pendidikan, dengan hasil yang konsisten menunjukkan manfaat pada peningkatan resiliensi, penurunan burnout, dan penguatan kapasitas atensi (Creswell, 2017; Gu et al., 2015). Oleh karena itu, MBSR kini dipandang sebagai salah

satu pendekatan berbasis mindfulness yang paling teruji secara ilmiah untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) efektif dalam mengurangi gejala kecemasan, depresi, dan stres, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dari penelitian bahwa program MBSR memberikan efek positif pada kesehatan fisik, seperti menurunkan tekanan darah dan peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh. Bahkan telah disesuaikan secara luas di belahan dunia untuk digunakan dalam berbagai konteks, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan perusahaan (Dawn *et al.*, 2020).

MBSR mengusung konsep *mindfulness*, yaitu sikap menerima serta kesadaran diri tanpa menghakimi terhadap situasi saat ini. Dengan *mindfulness*, seseorang dapat memfokuskan perhatian sepenuhnya pada diri sendiri dan situasi di sekitarnya. Seseorang dengan tingkat *mindfulness* tinggi cenderung lebih mampu mengatasi emosi negatifnya saat menghadapi situasi penuh tekanan dengan kehadiran pikiran yang penuh kesadaran. Sebaliknya, individu dengan tingkat *mindfulness* yang rendah mungkin lebih rentan terhadap reaksi berlebihan atau kecenderungan untuk terlalu terfokus pada kegagalan saat menghadapi tantangan (Choe *et al.*, 2020).

B. Pengertian

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) adalah sebuah intervensi psikologis berbasis *mindfulness meditation* yang dirancang untuk membantu individu menghadapi stres, rasa sakit, maupun kesulitan psikologis dengan cara mengembangkan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini. Program ini pertama kali dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn pada tahun 1979 di University of Massachusetts Medical School sebagai bagian dari klinik pengurangan stres (*Stress Reduction Clinic*) (Kabat-Zinn, 1982).

MBSR pada dasarnya adalah program terstruktur selama delapan minggu yang terdiri dari latihan meditasi, body scan, yoga, serta diskusi kelompok. Peserta dilatih

untuk menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh tanpa memberikan penilaian, serta mengembangkan sikap penerimaan dan keterbukaan terhadap pengalaman hidup (Kabat-Zinn, 1990). Dengan demikian, MBSR tidak hanya sekadar teknik relaksasi, tetapi sebuah pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis.

Menurut Bishop et al. (2004), praktik mindfulness yang menjadi inti MBSR menekankan dua komponen utama: (1) regulasi perhatian terhadap pengalaman saat ini, dan (2) orientasi sikap berupa keterbukaan, penerimaan, serta non-reaktivitas. Melalui praktik ini, individu belajar mengurangi kecenderungan untuk bereaksi secara otomatis terhadap stres dan menggantinya dengan respons yang lebih adaptif.

C. Tujuan

Tujuan utama dari program MBSR adalah memberikan keterampilan praktis dalam mengelola stres dan meningkatkan kualitas hidup. Kabat-Zinn (1990) menekankan bahwa tujuan MBSR bukan untuk menghilangkan stres sama sekali, melainkan untuk mengubah hubungan individu dengan stres sehingga dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik menjadi lebih adaptif.

Secara lebih rinci, tujuan MBSR dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Mengurangi gejala stres dan kecemasan Melalui peningkatan kesadaran terhadap pola pikir otomatis dan emosi negatif, individu belajar merespons stres dengan cara yang lebih tenang dan sadar (Khoury et al., 2015).
2. Meningkatkan regulasi emosi MBSR bertujuan melatih kemampuan individu dalam mengenali dan mengelola emosi tanpa harus menekan atau melawannya (Roemer et al., 2015).
3. Meningkatkan kualitas hidup Dengan berkurangnya gejala stres, kecemasan, maupun nyeri kronis, peserta MBSR dilaporkan memiliki peningkatan pada kualitas tidur, konsentrasi, serta kebahagiaan subjektif (Grossman et al., 2004).

4. Mendorong kesadaran diri – MBSR membantu individu menjadi lebih sadar terhadap tubuh, pikiran, dan lingkungannya, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih sehat dan bermakna (Shapiro et al., 2006).

D. Manfaat

Banyak penelitian telah menunjukkan manfaat MBSR pada berbagai aspek kesehatan fisik dan psikologis, baik pada populasi umum maupun pasien dengan kondisi medis tertentu. Beberapa manfaat utamanya antara lain:

1. Kesehatan Mental

MBSR terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan, depresi, dan stres. Meta-analisis oleh Khoury et al. (2015) menunjukkan bahwa MBSR memiliki efek signifikan dalam menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis, bahkan pada populasi yang sehat.

Selain itu, MBSR juga bermanfaat pada gangguan kecemasan dan depresi klinis. Penelitian oleh Hofmann et al. (2010) menemukan bahwa intervensi berbasis mindfulness, termasuk MBSR, mampu menurunkan gejala psikopatologi secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol.

2. Regulasi Emosi dan Resiliensi

MBSR meningkatkan kapasitas individu untuk mengelola emosi dengan cara yang sehat. Studi oleh Hölzel et al. (2011) menunjukkan bahwa praktik mindfulness berkaitan dengan perubahan struktur otak, termasuk peningkatan ketebalan korteks prefrontal yang berhubungan dengan regulasi emosi dan fungsi eksekutif.

Selain itu, MBSR juga berkontribusi pada peningkatan resiliensi terhadap stres, baik di kalangan tenaga kesehatan, guru, maupun mahasiswa yang sering menghadapi tekanan kerja atau akademik (Creswell, 2017).

3. Kesehatan Fisik

Selain pada kesehatan mental, MBSR juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik. Penelitian Hilton et al. (2017) menemukan bahwa MBSR

efektif dalam mengurangi persepsi nyeri kronis, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan pada obat analgesik.

Manfaat lain juga terlihat pada pasien dengan penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Carlson et al. (2003) melaporkan bahwa pasien kanker payudara dan prostat yang mengikuti MBSR mengalami peningkatan kualitas hidup, penurunan stres, serta pengurangan gejala mood negatif.

4. Konteks Pendidikan dan Organisasi

Dalam dunia pendidikan, MBSR terbukti membantu siswa dan mahasiswa dalam meningkatkan fokus, mengurangi kecemasan ujian, serta memperbaiki kemampuan kognitif (Zenner et al., 2014). Sedangkan di lingkungan kerja, MBSR membantu mengurangi burnout, meningkatkan kepuasan kerja, serta memperbaiki hubungan interpersonal di tempat kerja (Hülshager et al., 2013).

E. Aspek Mindfulness -Based Stress Reduction

Secara klinis program *Mindfulness-Based Stress Reduction* (MBSR) meliputi empat aspek penting (Zou et al., 2016), diantaranya:

1. Regulasi Perhatian: berkaitan dengan kemampuan menjaga konsentrasi dan fokus pada objek atau pengalaman tertentu, misalnya pernafasan dan sensasi tubuh, tanpa terpengaruh oleh rangsangan internal dan eksternal.
2. Kesadaran Tubuh: berkaitan dengan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran pada sensasi tubuh, dengan mengamati tanpa penilaian. Sensasi yang dapat dirasakan yaitu ketegangan, rasa sakit, dan pengalaman fisik lainnya.
3. Regulasi Emosional: berkaitan dengan kemampuan menyadari terhadap emosi yang muncul, merespon dengan cara yang terampil dan efektif, serta mengamati tanpa bereaksi atau merasa kewalahan.
4. Wawasan: kemampuan untuk mengembangkan pemahaman terkait pikiran, emosi, dan perilaku, dengan bersikap dan mencari tahu pikiran diri sendiri.

F. Komponen Utama Mindfulness -Based Stress Reduction

Program MBSR biasanya berlangsung selama delapan minggu dan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Latihan meditasi mindfulness
2. Body scan (kesadaran tubuh)
3. Yoga ringan
4. Diskusi kelompok
5. Latihan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari

G. Prinsip Dasar Mindfulness-Based Stress Reduction

MBSR berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Non-judging: Mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi.
2. Patience: Kesabaran dalam menerima pengalaman saat ini.
3. Beginner's Mind: Melihat segala sesuatu seolah-olah untuk pertama kali.
4. Trust: Mempercayai diri sendiri dan prosesnya.
5. Non-striving: Tidak berusaha memaksakan hasil tertentu.
6. Acceptance: Menerima pengalaman apa adanya.
7. Letting Go: Melepaskan keterikatan pada pikiran atau perasaan tertentu.

H. Tahapan Mindfulness-Based Stress Reduction

1. Minggu ke-1 pengenalan, latihan *body scan meditation* selama 30-45 menit, meditasi nafas 10 menit
2. Minggu ke-2 latihan *body scan meditation* selama 30-45 menit, *walking meditation* 10-15 menit
3. Minggu ke-3 latihan *mindful movement* (yoga ringan) 30-45 menit, meditasi duduk 20-30 menit
4. Minggu ke-4 latihan meditasi duduk 30-40 menit, latihan *mindful movement* (yoga ringan) 30-45 menit, mengukur stress

5. Minggu ke-5 Meditasi *Loving-Kindnes* (meditasi bersama teman) 20-30 menit, latihan *mindful movement* Bersama teman (yoga ringan) 20-30 menit
6. Minggu ke-6 latihan meditasi duduk 20-30 menit, latihan *mindful movement* (yoga ringan) 20-30 menit
7. Minggu ke-7 Latihan kombinasi (*body scan meditation*, *mindful movement* (yoga ringan), meditasi duduk) 45-60 menit
8. Minggu ke-8 Meditasi Gabungan (meditasi nafas, Meditasi *Loving-Kindnes*, *body scan meditation*), mengukur kualitas hidup.

I. Mekanisme Kerja Mindfulness-Based Stress Reduction

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) bekerja melalui pengembangan kesadaran penuh (*mindfulness*) yang dilatih secara sistematis. Mekanisme kerjanya dapat dijelaskan dari beberapa aspek:

1. Regulasi Perhatian

MBSR melatih individu untuk mengarahkan dan mempertahankan perhatian pada momen saat ini, misalnya melalui fokus pada napas atau sensasi tubuh. Kemampuan ini membantu mengurangi kecenderungan pikiran untuk berkelana (*mind wandering*) yang sering dikaitkan dengan stres dan kecemasan (Tang et al., 2015).

2. Regulasi Emosi

Dengan meningkatkan kesadaran tanpa menghakimi terhadap pengalaman emosional, MBSR membantu individu merespons emosi negatif secara lebih adaptif. Studi neuroimaging menunjukkan adanya perubahan pada aktivitas amigdala dan peningkatan keterhubungan korteks prefrontal, yang berperan dalam pengendalian emosi (Hölzel et al., 2011)

3. Peningkatan kesadaran tubuh (*interoceptive awareness*)

Melalui latihan seperti *body scan*, peserta MBSR menjadi lebih peka terhadap sinyal tubuh, sehingga dapat mengenali gejala stres sejak dini dan mengembangkan respons yang lebih sehat (Mehling et al., 2012).

4. Perubahan kognitif

Latihan mindfulness menurunkan kecenderungan *rumination* (pengulangan pikiran negatif) dan meningkatkan *cognitive flexibility*, yang berkontribusi pada penurunan gejala depresi dan kecemasan (Gu et al., 2015).

5. Resiliensi stres fisiologis

Beberapa penelitian melaporkan bahwa MBSR dapat memodulasi sistem saraf otonom dan aksis hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA axis), sehingga menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan respons relaksasi tubuh (Pascoe et al., 2017).

J. Indikasi Mindfulness-Based Stress Reduction

MBSR telah banyak diteliti dan direkomendasikan dalam berbagai kondisi psikologis maupun medis. Beberapa indikasi yang sering dijumpai antara lain:

1. Gangguan Kecemasan dan Depresi

MBSR efektif menurunkan gejala kecemasan dan depresi pada populasi klinis maupun non-klinis (Khoury et al., 2013).

2. Stres Kronis

Baik pada pekerja, mahasiswa, maupun pasien medis, MBSR terbukti menurunkan tingkat stres, meningkatkan resiliensi, dan mengurangi burnout (Creswell, 2017)

3. Penyakit Kronis dengan Nyeri

Program ini awalnya dikembangkan untuk pasien dengan nyeri kronis, dan hingga kini tetap menjadi intervensi yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penderita nyeri punggung, kanker, fibromyalgia, serta artritis (Kabat-Zinn, 1982; Hilton et al., 2017).

4. Gangguan Tidur

MBSR dapat memperbaiki kualitas tidur dengan menurunkan hiperaktivasi kognitif sebelum tidur dan meningkatkan relaksasi (Winbush et al., 2007)

5. Kondisi Medis Terkait Stres

Misalnya hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan sindrom iritasi usus besar (IBS), di mana MBSR membantu menurunkan gejala dan meningkatkan regulasi tubuh terhadap stres (Bohlmeijer et al., 2010).

6. Populasi Umum

MBSR tidak hanya terbatas untuk pasien medis, tetapi juga bermanfaat bagi orang sehat untuk meningkatkan *well-being*, kapasitas atensi, dan hubungan sosial (Shapiro et al., 2008).

K. Kontraindikasi Mindfulness-Based Stress Reduction

Walaupun secara umum aman, MBSR tidak selalu sesuai untuk semua individu. Beberapa kontraindikasi relatif yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Gangguan Psikotik Akut

Individu dengan psikosis aktif (misalnya skizofrenia dengan halusinasi berat) berisiko mengalami eksaserbasi gejala ketika melakukan meditasi intensif (Lindahl et al., 2017).

2. Trauma Berat dan PTSD Akut

Pada individu dengan trauma berat, praktik mindfulness yang mengarahkan perhatian pada tubuh bisa memicu *flashback* atau *dissociation*. Pendekatan hati-hati dengan adaptasi khusus diperlukan (Treleaven, 2018).

3. Depresi Berat dengan Ide Bunuh Diri Aktif

Meskipun MBSR bermanfaat pada depresi ringan-sedang, individu dengan risiko bunuh diri tinggi sebaiknya mendapatkan stabilisasi terlebih dahulu sebelum mengikuti program (Segal et al., 2013).

4. Kesulitan Fisik Tertentu

Beberapa latihan MBSR mencakup *yoga mindful*. Pasien dengan keterbatasan fisik harus menyesuaikan atau menghindari gerakan tertentu untuk mencegah cedera.

5. Kurangnya Motivasi atau Kesiapan

Program MBSR memerlukan komitmen latihan rutin. Individu yang tidak siap atau enggan berlatih dapat mengalami frustrasi atau ketidakoptimalan manfaat.

A background image showing a man and a woman in a professional setting, possibly a meeting or a workshop. The man is on the left, wearing glasses and a light-colored shirt, looking towards the woman. The woman is on the right, wearing a hijab and a light-colored top, smiling and looking towards the man. They are sitting at a table with various papers and a laptop. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text.

BAB 7

MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION UNTUK STRESS PENDERITA HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan global yang menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, stroke, dan gagal ginjal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa prevalensi hipertensi terus meningkat, terutama di negara berkembang, sehingga menimbulkan beban signifikan bagi sistem kesehatan (World Health Organization, 2021). Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah adalah stres psikologis. Stres yang tidak terkelola dapat memicu aktivasi sistem saraf simpatis dan meningkatkan sekresi hormon kortisol, yang pada gilirannya menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah (Spruill, 2010).

Dalam konteks ini, pendekatan non-farmakologis untuk mengurangi stres menjadi sangat penting sebagai terapi pendamping pengobatan medis. Salah satu intervensi yang mendapat perhatian luas adalah Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), sebuah program yang dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn pada tahun 1979. Program MBSR berfokus pada latihan meditasi, kesadaran penuh, serta gerakan tubuh sederhana seperti yoga, yang bertujuan membantu individu mengelola stres dengan lebih adaptif (Kabat-Zinn, 2003).

Beberapa penelitian menunjukkan efektivitas MBSR dalam menurunkan tingkat stres sekaligus memperbaiki tekanan darah pada pasien hipertensi. Sebuah tinjauan literatur melaporkan bahwa intervensi mindfulness mampu menurunkan

skor stres positif maupun negatif pada penderita hipertensi, sekaligus berkontribusi pada pengendalian tekanan darah (Mu'afiro, Suwito, & Kiaonarni, 2024). Demikian pula, meta-analisis menemukan bahwa MBSR secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kecemasan, depresi, dan tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi (Hughes et al., 2013).

Selain memberikan manfaat fisiologis, MBSR juga meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien hipertensi. Latihan kesadaran penuh membantu pasien menyadari pola pikir negatif, mengurangi reaktivitas emosional, dan membangun sikap penerimaan terhadap kondisi kesehatan mereka. Hal ini penting karena pasien hipertensi sering kali mengalami beban psikologis akibat keterbatasan gaya hidup maupun kekhawatiran komplikasi (Loucks et al., 2015).

Dengan demikian, penerapan MBSR sebagai terapi komplementer bagi penderita hipertensi dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi dampak stres, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu mengendalikan tekanan darah. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara intervensi psikologis dan medis, sekaligus menegaskan pentingnya perawatan holistik dalam manajemen hipertensi.

B. Penelitian Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Stress Pada Penderita Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) berpengaruh terhadap penurunan skor stres pada wanita penderita hipertensi. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan efektivitas MBSR sebagai strategi non-farmakologis untuk menurunkan stres. Penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2025) menemukan bahwa penerapan program MBSR pada pasien dengan hipertensi nokturnal secara signifikan menurunkan tingkat stres dan kecemasan tanpa menimbulkan efek samping, sehingga dapat direkomendasikan sebagai intervensi komplementer. Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian Aliftitah dan Oktavianisya (2025) pasien hipertensi

yang mendapatkan MBSR mengalami penurunan skor stres dan tekanan darah yang lebih signifikan dibanding kelompok kontrol.

MBSR bekerja dengan menyeimbangkan sistem saraf otonom, khususnya melalui penurunan aktivitas saraf simpatis dan peningkatan aktivitas parasimpatis. Aktivitas simpatis yang berlebihan pada penderita hipertensi menyebabkan peningkatan denyut jantung, vasokonstriksi, serta peningkatan sekresi hormon stres, seperti katekolamin dan kortisol. Latihan meditasi dan pernapasan dalam program MBSR mampu menurunkan respons simpatis tersebut, sehingga tercapai kondisi relaksasi. MBSR dapat menurunkan aktivasi hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA axis) yang menjadi pusat respons stres, sehingga kadar kortisol dalam tubuh menurun. Penurunan kadar kortisol inilah yang berkontribusi pada perbaikan skor stres pada pasien hipertensi. Menurut Sahish dan Bharti (2025). Teknik meditasi pada MBSR membuat otak pada kondisi alfa yang membuat perasaan tenang, positif, penurunan kecemasan dan penurunan stress (Brown dan Ryan, 2003)

MBSR melatih individu untuk hadir pada saat ini (present moment awareness) dan menerima pengalaman tanpa menghakimi (non-judgmental awareness). Pola pikir ini membantu pasien untuk mengurangi ruminasi, kecemasan, dan respon emosional berlebihan terhadap stresor. Penelitian Mu'afiro et al. (2024) melaporkan bahwa pasien hipertensi yang mengikuti program MBSR merasa lebih tenang, mampu mengendalikan emosinya, dan tidak mudah terpancing oleh pikiran negatif. Dengan meningkatnya keterampilan regulasi emosi, persepsi stres yang dialami pasien berkurang secara signifikan, yang kemudian tercermin pada skor stres yang lebih rendah.

MBSR melatih individu untuk mengamati, menggambarkan, menerima segala pikiran dan sensasi yang muncul. Aspek menggambarkan dapat mengajarkan individu agar tidak membuat penilaian dan alasan terhadap kondisi yang dialami saat ini. Individu dapat menggambarkan potensi diri, penerimaan diri dan penguatan diri sehingga menurunkan stress (Bears, Smith, 2004). MBSR juga

memodifikasi proses kognisi dan afeksi yang mempengaruhi regulasi emosi, sensasi fisik dan keyakinan diri, sehingga menurunkan stress (Kabat 2016)

MBSR dapat meningkatkan aktivitas pada prefrontal cortex (PFC) yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi, sekaligus menurunkan hiperaktivitas amigdala yang berperan dalam respon stress dan merilekskan pikiran. MBSR mampu memodulasi aktivitas saraf sehingga menurunkan reaktivitas terhadap stresor. Perubahan ini menunjukkan adanya proses neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak beradaptasi membentuk jalur saraf baru yang lebih adaptif dalam menghadapi stressor sehingga menurunkan stress. (Tomasino, 2016; Damarlapally et al. (2025)

MBSR juga mempengaruhi system saraf dengan mengaktifkan prefrontal kiri, sehingga merubah emosi menjadi positif dan proses regulasi emosi positif menurunkan regulasi ekspresi gen proinflamasi sehingga menurunkan stress (Keng, 2011). Selain itu MBSR meningkatkan resting state functional connectivity antara default mode network dengan daerah regulasi stress, sehingga menurunkan stress

MBSR meliputi body scan, mindful breathing, dan gentle yoga memperkuat hubungan antara tubuh dan pikiran (mind-body connection). Melalui latihan ini, pasien menjadi lebih sadar terhadap sensasi tubuh dan gejala stres, sehingga dapat melakukan tindakan relaksasi lebih cepat sebelum stres berkembang lebih berat Suwito et al. (2024)

A background image showing a man and a woman in a professional setting, possibly a meeting or a collaborative work environment. The man is on the left, wearing glasses and a light-colored shirt, looking towards the woman. The woman is on the right, wearing a hijab and a light-colored top, smiling and looking towards the man. They are sitting at a table with various items on it, including a laptop, a notebook, and some papers. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text, and a bookshelf with books.

BAB 8

MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION UNTUK TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama di seluruh dunia yang berdampak besar terhadap morbiditas dan mortalitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan lebih dari 1,28 miliar orang dewasa mengalami hipertensi, dengan hanya kurang dari separuhnya yang terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan yang adekuat. Jika tidak ditangani secara optimal, hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal kronis, dan komplikasi kardiovaskular lainnya (Mills et al., 2020). Di Indonesia, hipertensi juga menjadi salah satu penyumbang utama angka kesakitan dan kematian, serta menimbulkan beban biaya kesehatan yang signifikan bagi individu maupun negara.

Penyebab hipertensi bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor genetik, pola makan tinggi natrium, kurangnya aktivitas fisik, serta faktor psikososial seperti stres kronis. Stres psikologis terbukti berperan dalam peningkatan tekanan darah melalui aktivasi sistem saraf simpatis dan aksis hipotalamus–pituitari–adrenal. Aktivasi ini memicu peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang pada akhirnya dapat mengganggu regulasi vaskular serta mempertahankan kondisi tekanan darah tinggi (Spruill, 2010). Oleh karena itu, pengelolaan hipertensi idealnya tidak hanya mengandalkan terapi farmakologis, tetapi juga mencakup

pendekatan non-farmakologis yang menasar aspek gaya hidup dan psikologis pasien.

Salah satu intervensi non-farmakologis yang berkembang pesat adalah Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Program ini dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn pada akhir tahun 1970-an sebagai pendekatan terstruktur selama delapan minggu yang mencakup latihan meditasi kesadaran penuh, yoga lembut, serta diskusi kelompok untuk meningkatkan penerimaan terhadap pengalaman hidup tanpa reaktivitas berlebihan (Kabat-Zinn, 2013). MBSR terbukti efektif dalam menurunkan stres, meningkatkan regulasi emosi, serta memperbaiki kualitas hidup penderita berbagai penyakit kronis, termasuk hipertensi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa MBSR memiliki potensi dalam membantu menurunkan tekanan darah. Studi meta-analisis yang dilakukan oleh Blom et al. (2020) dan Zhang et al. (2021) melaporkan bahwa intervensi berbasis mindfulness dapat menghasilkan penurunan tekanan darah sistolik maupun diastolik yang signifikan. Efek ini diperkirakan terjadi melalui mekanisme biologis dan psikologis, seperti menurunkan aktivitas saraf simpatis, meningkatkan tonus parasimpatis, memperbaiki variabilitas denyut jantung, serta menurunkan kadar kortisol (Tang et al., 2022). Selain itu, MBSR juga meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kecemasan, dan membantu pasien membangun kesadaran diri yang lebih baik terhadap perilaku gaya hidup yang memengaruhi tekanan darah (Abbott et al., 2019).

B. Penelitian Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada Wanita penderita hipertensi. Penelitian oleh Lee et al. (2025) menemukan bahwa pasien dengan hipertensi nokturnal yang menjalani program MBSR mengalami penurunan tekanan darah secara signifikan. Demikian pula, penelitian Aliftitah dan Oktavianisya (2025)

menunjukkan bahwa intervensi MBSR tidak hanya menurunkan tingkat stres, tetapi juga menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi.

Hasil penelitian Loucks et al. 2023 menemukan bahwa adaptasi pelatihan mindfulness untuk perilaku penurunan tekanan darah berhasil menghasilkan penurunan tekanan darah sistolik yang bermakna secara klinis pada peserta dengan tekanan darah meningkat. Perubahan tersebut menegaskan bahwa intervensi mindfulness bukan sekadar memperbaiki kesehatan mental, tetapi juga dapat memberi dampak fisiologis nyata yang relevan dengan outcome klinis hipertensi.

Secara fisiologis, tekanan darah sangat dipengaruhi oleh aktivitas sistem saraf otonom, khususnya keseimbangan antara saraf simpatis dan parasimpatis. Pada penderita hipertensi, aktivitas simpatis cenderung dominan, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, dan peningkatan resistensi perifer. Program MBSR yang menekankan pada latihan pernapasan, meditasi, dan relaksasi, terbukti meningkatkan tonus parasimpatis sekaligus menurunkan aktivitas simpatis. Mekanisme ini menghasilkan vasodilatasi, penurunan resistensi vaskuler sistemik, dan pada akhirnya menurunkan tekanan darah. MBSR juga menyeimbangkan saraf otonom yang membantu tubuh menjaga kestabilan tekanan darah. MBSR membuat seseorang menjadi rileks, menghambat respon stress pada system saraf simpatik sehingga menurunkan tekanan darah (Hermanto,2014).

MBSR juga bekerja melalui mekanisme hormonal. Stres kronis pada penderita hipertensi diketahui mengaktifasi hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA axis), yang berujung pada peningkatan sekresi kortisol dan katekolamin. Kedua hormon ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dengan cara meningkatkan retensi natrium, memperkuat vasokonstriksi, dan menaikkan curah jantung. MBSR mampu menurunkan hiperaktivasi HPA axis dan mengurangi sekresi kortisol (Mu’afiro et al., 2024). Penurunan hormon stres ini menurunkan beban hemodinamik pada jantung dan pembuluh darah, sehingga tekanan darah dapat terkendali lebih baik.

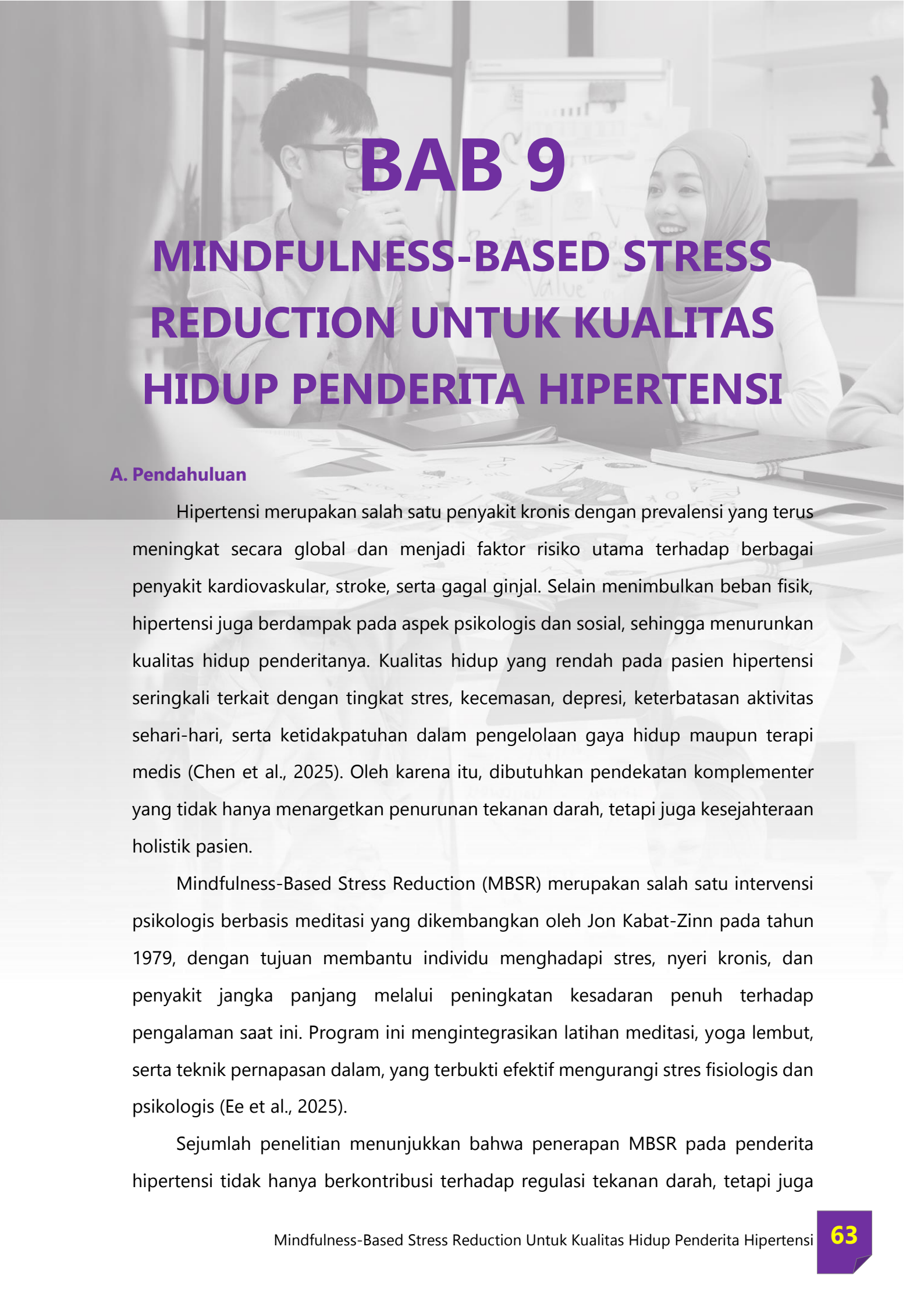
MBSR menurunkan produksi hormon kelenjar adrenal dan menurunkan system saraf simpatis. System saraf simpatis yang menurun menyebabkan penurunan pada detak jantung. Penstabilan pernapasan pernapasan dan penurunan tekanan darah (Nevid, Rathus, & Green, 2005).

Faktor psikologis juga berperan besar dalam pengendalian tekanan darah. Penderita hipertensi yang mengalami stres psikologis cenderung mengalami fluktuasi tekanan darah yang lebih besar dibanding pasien tanpa stres. MBSR membantu individu untuk meningkatkan regulasi emosi, mengurangi ruminasi, serta merespons stresor dengan lebih adaptif. MBSR secara konsisten menurunkan skor stres sekaligus menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi (Mu'afiro, Nursalam, Suwito, Kiaonarni, & Hidayati, 2024).

MBSR memusatkan perhatian, pikiran, membantu mengurangi stress, mengarahkan suasana hati yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam pengendalian emosi. MBSR memberikan rasa rileks dan menyegarkan fisik dan psikologis. MBSR mempengaruhi saraf pusat dengan merilekskan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lancar dan menurunkan tekanan darah (Zou et al, 2018)

MBSR dilakukan dengan body scan, meditasi, mindful breathing, dan gentle yoga, berfungsi memperkuat hubungan tubuh-pikiran (mind-body integration). Dengan meningkatnya kesadaran tubuh, pasien menjadi lebih mampu mengenali tanda-tanda awal stres, sehingga dapat melakukan strategi relaksasi sebelum stres berdampak pada peningkatan tekanan darah (Mu'afiro, Nursalam, Suwito, Kiaonarni, & Hidayati, 2024).

Teknik meditasi pada MBSR akan menghasilkan gelombang alfa pada otak. Gelombang alfa mempengaruhi sekresi hormon norepineprin, serotonin dan beta endorphin sehingga menurunkan tekanan darah (Cozzolino, 2006).

A background image showing a man and a woman in a professional setting, possibly a meeting or a classroom. The man is on the left, wearing glasses and a light-colored shirt, looking towards the woman. The woman is on the right, wearing a hijab and a light-colored top, smiling and looking towards the man. They are sitting at a table with papers and a laptop. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text.

BAB 9

MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION UNTUK KUALITAS HIDUP PENDERITA HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat secara global dan menjadi faktor risiko utama terhadap berbagai penyakit kardiovaskular, stroke, serta gagal ginjal. Selain menimbulkan beban fisik, hipertensi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial, sehingga menurunkan kualitas hidup penderitanya. Kualitas hidup yang rendah pada pasien hipertensi seringkali terkait dengan tingkat stres, kecemasan, depresi, keterbatasan aktivitas sehari-hari, serta ketidakpatuhan dalam pengelolaan gaya hidup maupun terapi medis (Chen et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komplementer yang tidak hanya menargetkan penurunan tekanan darah, tetapi juga kesejahteraan holistik pasien.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) merupakan salah satu intervensi psikologis berbasis meditasi yang dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn pada tahun 1979, dengan tujuan membantu individu menghadapi stres, nyeri kronis, dan penyakit jangka panjang melalui peningkatan kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini. Program ini mengintegrasikan latihan meditasi, yoga lembut, serta teknik pernapasan dalam, yang terbukti efektif mengurangi stres fisiologis dan psikologis (Ee et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBSR pada penderita hipertensi tidak hanya berkontribusi terhadap regulasi tekanan darah, tetapi juga

meningkatkan aspek kualitas hidup seperti kesejahteraan emosional, kepuasan sosial, serta fungsi kognitif (Yalçın et al., 2025; Alexander, 2025). Selain itu, MBSR juga terbukti membantu meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, memperbaiki kualitas tidur, serta mengurangi kecemasan yang sering kali memperburuk kondisi hipertensi (Damarlapally et al., 2025; Ramos-Galarza et al., 2025).

Dengan sifatnya yang non-farmakologis, murah, dan dapat dilakukan secara berkelanjutan, MBSR menawarkan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Pendekatan ini sejalan dengan tren pengelolaan penyakit kronis yang menekankan pentingnya pemberdayaan pasien serta integrasi antara intervensi medis dan psikososial. Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi efektivitas MBSR sebagai terapi komplementer dalam meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi, baik di tingkat klinis maupun komunitas.

B. Penelitian Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Untuk Kualitas Hidup Pada Penderita Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) berpengaruh positif terhadap peningkatan skor kualitas hidup pada Wanita penderita hipertensi. Hal ini sesuai dengan penelitian Lee et al. (2025) juga mengonfirmasi bahwa MBSR meningkatkan coping mechanism dan mengurangi beban psikologis, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Hasil penelitian Babak, 2022 mengonstruksi MBSR selama 12 minggu untuk perempuan dewasa hipertensi dan menemukan penurunan signifikan tekanan darah sistolik dan diastolik serta peningkatan skor kualitas hidup dan penurunan stres serta kecemasan. Selanjutnya, uji klinis fase 2 MB-BP (Mindfulness-Based Blood Pressure Reduction), modifikasi MBSR yang secara khusus menarget perilaku terkait hipertensi, menunjukkan peningkatan kesadaran interoseptif dan kepatuhan

terhadap diet DASH pada penderita dengan tekanan darah meningkat ((Babak, Motamedi, Mousavi, & Darestani, 2022). Hasil penelitian Loucks, 2023 melaporkan penurunan tekanan darah sistolik bermakna secara klinis. Mindfulness meningkatkan regulasi diri, menurunkan reaktivitas stres dan marker inflamasi semua berkaitan dengan perbaikan hipertensi dan kualitas hidup (Loucks, et al., 2023).

Chen (2024) menjelaskan bahwa MBSR meningkatkan regulasi diri, kepatuhan terhadap pengobatan, serta perilaku sehat seperti diet dan aktivitas fisik. Selain itu, mindfulness menurunkan reaktivitas stres fisiologis serta penanda inflamasi yang turut berkontribusi terhadap perbaikan tekanan darah. Mekanisme-mekanisme ini pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup penderita hipertensi (Chen, Liu, & Du, 2024).

Kualitas hidup penderita hipertensi dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Intervensi MBSR terbukti memberi dampak positif pada keempat aspek tersebut. MBSR dilihat dari Aspek fisik dengan Penurunan tekanan darah, perbaikan kualitas tidur, serta peningkatan energi harian membuat pasien lebih mampu menjalani aktivitas sehari-hari. MBSR dari Aspek psikologis dapat mengurangi kecemasan, depresi, serta stres, yang tercermin dalam peningkatan skor domain kesehatan mental pada instrumen kualitas hidup. MBSR dari Aspek sosial dengan menurunnya ketegangan emosional, interaksi sosial pasien menjadi lebih baik. Peningkatan kesabaran, empati, dan keterbukaan pada pengalaman membantu memperbaiki hubungan interpersonal. MBSR dari Aspek spiritual menekankan penerimaan diri dan hidup pada saat ini. Hal ini meningkatkan rasa syukur, makna hidup, serta penerimaan terhadap kondisi kronis, sehingga memperkuat kesejahteraan spiritual pasien (Hasna, Meilianingsih, & Sugiyanto, 2023).

Salah satu faktor utama rendahnya kualitas hidup pada penderita hipertensi adalah tingginya tingkat stres dan kecemasan. Pasien hipertensi sering mengalami perasaan khawatir mengenai komplikasi penyakit, kepatuhan minum obat, dan

pembatasan gaya hidup. MBSR membantu individu mengembangkan kesadaran penuh (mindfulness) terhadap pikiran dan perasaan, sehingga mereka dapat mengelola stres secara lebih adaptif. Menurut Mu'afiro et al. (2024), pasien hipertensi yang menjalani MBSR menunjukkan peningkatan relaksasi, ketenangan emosional, dan penurunan reaktivitas terhadap stresor. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, karena pasien merasa lebih mampu mengendalikan kondisi emosionalnya dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.

Selain aspek psikologis, kualitas hidup juga dipengaruhi oleh kondisi fisik pasien. Stres kronis dapat memperburuk hipertensi dan menurunkan kualitas tidur, energi, dan vitalitas. MBSR yang melibatkan meditasi, pernapasan dalam, dan body scan terbukti meningkatkan relaksasi, menurunkan denyut jantung, dan memperbaiki kualitas tidur (Sahish & Bharti, 2025). Pasien hipertensi yang mengalami tidur lebih baik dan kelelahan berkurang akan merasakan peningkatan fungsi fisik, yang secara langsung meningkatkan dimensi kualitas hidup mereka. Dengan demikian, pengaruh MBSR terhadap kualitas hidup dapat dijelaskan melalui peningkatan kesehatan fisik yang diperoleh dari efek fisiologis latihan mindfulness. MBSR dapat membuat tubuh menjadi rileks, mengurangi sakit kepala, mengurangi pegal-pegal, pikiran menjadi tenang, afirmasi yang positif sehingga meningkatkan kualitas hidup (Park&Han, 2017)

MBSR memodifikasi aktivitas otak yang berhubungan dengan kesejahteraan psikologis. Latihan ini meningkatkan aktivitas prefrontal cortex (PFC) yang berperan dalam regulasi emosi dan pengambilan keputusan, sekaligus menurunkan hiperaktivitas amigdala yang terkait dengan kecemasan (Damarlapally et al., 2025). Perubahan ini berkontribusi pada peningkatan subjective well-being, yang merupakan salah satu indikator penting kualitas hidup. Dengan kata lain, MBSR tidak hanya mengurangi tekanan darah dan stres, tetapi juga menumbuhkan perasaan positif, ketenangan batin, dan makna hidup yang lebih besar pada pasien hipertensi. MBSR dapat mengarah pada pemikiran positif, rasa cinta pada diri sendiri,

penurunan kecemasan, penurunan stress dan tekanan psikologis secara keseluruhan. MBSR dapat meningkatkan Kesehatan mental, fisik, kognitif, afektif dan interpersonal sehingga meningkatkan kualitas hidup (Fazia, 2020).

MBSR bertujuan mencapai kemampuan untuk memahami kondisi saat ini dan menentukan untuk berubah atau tetap sehingga menerima kondisi saat ini. Individu yang melakukan MBSR akan menyadari perbedaan dirinya dengan orang lain dan menerima dirinya apa adanya tanpa menghakimi sehingga dapat memanfaatkan hidupnya lebih produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya (pratikta, 2020; Saputra, 2016).

MBSR meningkatkan fungsi yang optimal serta mencegah gangguan neurologic dan neuropsikiatri. MBSR dapat mengurangi stress, kelelahan, mental distress dan gejala somatic sehingga meningkatkan kesejahteraan diri, compassion dan kepuasan kerja sehingga meningkatkan kualitas hidup life (Janssen, Heerkens, Kuijer, Heijden, & Engels, 2018).

MBSR membuat individu memahami perasaan dan sensasi yang dialami saat ini bersifat sementara atau tidak ada segala sesuatu yang abadi. Hal ini membuat individu memiliki persepsi baru bahwa sesuatu ada masanya. Individu mampu menumbuhkan persepsi bahwa kondisi sakit yang dialami tidak menjadikannya kehilangan kemampuan beraktivitas. Individu akan yakin bahwa kondisi tubuh akan membaik dengan berkurangnya keluhan. Persepsi baru yang dimiliki individu tersebut menjauhkan dari pikiran dan emosi negative sehingga dapat memperbaiki fisik dan psikologisnya yang akan meningkatkan kualitas hidupnya (Chambers, Lo, & Allen, 2008).

MBSR dilakukan dengan penuh kesadaran yang dapat membuat seseorang focus dan sadar seutuhnya terhadap apa yang sedang dilakukan saat ini. Seseorang mampu memberi makna pada tiap kegiatan sehari-hari yang dilakukannya sehingga tidak kehilangan peran meskipun dalam kondisi sakit. Saat seseorang mampu berperan dalam kehidupannya maka keyakinan dirinya akan meningkat. MBSR membuat seseorang menerima dirinya tanpa menilai yang dilakukan berulang dapat

mencegah munculnya pikiran negatif dan penilaian negative pada diri sendiri sehingga berfokus pada masa kini dan melakukan aktivitas sesuai kemampuannya yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Munazilah & Hasanah, 2018).

Kualitas hidup pasien hipertensi juga ditentukan oleh dimensi sosial. MBSR sering dilakukan dalam kelompok, sehingga menciptakan dukungan sosial yang penting bagi pasien. Melalui pengalaman berbagi dan latihan bersama, pasien merasa tidak sendirian dalam menghadapi penyakitnya. Menurut Mu'afiro et al. (2024), MBSR dapat meningkatkan interaksi sosial, menumbuhkan rasa empati, dan memperkuat hubungan interpersonal. Dengan meningkatnya kepuasan dalam hubungan sosial, dimensi kualitas hidup yang berkaitan dengan fungsi sosial juga mengalami perbaikan (Mu'afiro, Nursalam, Suwito, Kiaonarni, & Hidayati, 2024)

PENUTUP

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) terbukti memberikan manfaat signifikan bagi penderita hipertensi, terutama terkait penurunan stres, stabilisasi tekanan darah, dan perbaikan kualitas tidur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan kesadaran penuh mampu menurunkan tekanan darah malam hari (nocturnal blood pressure) serta memperbaiki gejala mood dan kualitas tidur pada pasien hipertensi (Lee et al., 2025). Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa intervensi berbasis mindfulness berperan dalam mengurangi aktivasi sistem saraf simpatis, menurunkan hormon stres, serta meningkatkan keseimbangan psikologis pasien.

Selain itu, praktik MBSR yang meliputi meditasi, pernapasan sadar, dan yoga ringan bukan hanya mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengelolaan hipertensi non-farmakologis. Dampak positif pada kualitas tidur menjadi salah satu aspek penting, mengingat gangguan tidur dapat memperburuk tekanan darah dan mempercepat komplikasi kardiovaskular.

Dengan demikian, MBSR dapat direkomendasikan sebagai terapi komplementer yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah untuk mendukung pengendalian hipertensi. Integrasi MBSR ke dalam program perawatan rutin diharapkan mampu membantu pasien tidak hanya dalam mengelola tekanan darah, tetapi juga mencapai kualitas hidup yang lebih baik secara menyeluruh.

REFERENSI

- Aliftitah, & Oktavianisya. (2025). Pengaruh Terapi MBSR Terhadap Tekanan Darah dan Tingkat Stress pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(1), 35-43. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/9661/3888>.
- Babak, Motamedi, Mousavi, & Darestani. (2022). Effects of mindfulness-based stress reduction on blood pressure, mental health, and quality of life in hypertensive adult women: a randomized clinical trial study. *The Journal of Tehran University Heart Center*, 17(3), 127. <https://doi/10.18502/jthc.v17i3.10845>.
- Chambers, Lo, B. C., & Allen, N. B. (2008). The impact of intensive mindfulness training on attentional control, cognitive style, and affect. *Cognitive therapy and research*, 32(3), 303-322. <https://doi.org/10.1007/s10608-007-9119-0>.
- Chen, Liu, H., & Du, S. (2024). Effect of mindfulness-based interventions on people with prehypertension or hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Cardiovascular Disorders*, 24(1), 104. <https://doi.org/10.1186/s12872-024-03746-w>.
- Conversano, Orrù, Pozza, Miccoli, Ciacchini, Marchi, & Gemignani. (2021). Is mindfulness-based stress reduction effective for people with hypertension? A systematic review and meta-analysis of 30 years of evidence. *International journal of environmental research and public health*, 18(6), 2882. <https://doi.org/10.3390/ijerph18062882>.
- Cozzolino, W. (2006). *The Nuts and Bolts of Meditation*. California: Raissa Publisher.
- Damarlapally, Binti, N. U., Winson, T., Basu, P., Tejani, V., Damarlapally, K., & Khena, D. (2025). Overall Effect of Stress Reduction Interventions on Cardiovascular Outcomes (Both Qualitative and Quantitative): A Systematic Review and Meta-Analysis. *Circulation*, 151(Suppl_1), 1025. https://doi.org/10.1161/cir.151.suppl_1.P102.
- Fazia, Bubbico, F., Iliakis, I., Salvato, G., Berzuini, G., Bruno, S., & Bernardinelli, L. (2020). Short-term meditation training fosters mindfulness and emotion regulation: A pilot study. *Frontiers in psychology*, 11, 558803. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558803>.

Hasna, Meilianingsih, & Sugiyanto. (2023). Stres Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Hipertensi di Puskesmas Garuda Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan Indonesia Florence Nightingale*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.34011/jkifn.v3i1.1352>.

Hermanto, J. (2014). Pengaruh Pemberian Meditasi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Unit Sosial Rehabilitasi Pucang Gading Semarang. *Jurnal Keperawatan*, 1(9), 1-9.

Indonesia., S. K. (2023). Laporan Survei Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Janssen, Heerkens, Kuijer, W., Heijden, V. D., & Engels, J. (2018). Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on employees' mental health: A systematic review. *PloS one*, 13(1), 0191332. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191332>.

Lee, K. P., Yeung, N. C., Xu, Z., Zhang, D., Yu, C. P., & Wong, S. Y. (2021). Effect and Acceptability of Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Patient With Elevated Blood Pressure or Hypertension: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Hypertension*, 39, 325. <https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000748252.13174.15>.

Lee, Wang, Ng, S. N., Sit, R., Ying, C., Yip, B. H., Wong, S. (2025). Feasibility and preliminary effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on patients with nocturnal hypertension: A pilot randomized controlled trial. *Journal of Hypertension*, 43(Suppl 1), 46. <https://doi.org/10.1097/01.hjh.0001115632.96757.51>.

Loucks, Nardi, W. R., McGowan, S. K., Osborne, M. J., Hossain, N. I., Britton, W. B., & Haring, R. C. (2023). Adapted mindfulness training for elevated blood pressure: A randomized clinical trial. *Journal of the American Heart Association*, 12(5), 028796. <https://doi.org/10.1161/JAHA.122.028796>.

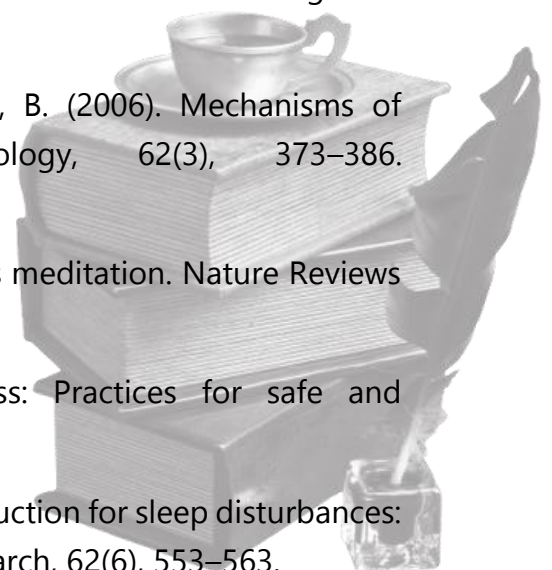
Mir, I., John, Humayra, Khan, Chong, & Manan. (2024). Effect of mindfulness-based meditation on blood pressure among adults with elevated blood pressure and hypertension: A systematic review of randomized controlled trials. *Complementary therapies in medicine*, 85, 103084. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2024.103084>.

Mu'afiro, Nursalam, Suwito, J., Kiaonarni, O. W., & Hidayati, S. (2024). The effect of mindfulness interventions on blood pressure and stress in hypertensive patients: A Literature Review. *Gaceta Médica de Caracas*, 132., 266. <https://doi.org/10.47307/GMC.2024.132.s2.14>.

- Munazilah, & Hasanah, N. (2018). Program Mindfulness Based Stress Reduction untuk Menurunkan Kecemasan pada Individu dengan Penyakit Jantung Koroner. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GAMAJPP)*, 4(1), 22-32. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.45346>.
- Nasrani, & Purnawati. (2015). Perbedaan Tingkat Stres Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Peserta Yoga Di Kota Denpasar. *Jurnal Medika Udayana*, 4(12), 1-7.
- Nevid, Rathus, S. A., & Green, B. (2005). Psikologi abnormal (edisi 5/jilid 1). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Park, S. H., & Han, K. S. (2017). Blood pressure response to meditation and yoga: a systematic review and meta-analysis. *The journal of alternative and complementary medicine*, 23 (9), 685-695. <https://doi.org/10.1089/acm.2016.0234>.
- Pratikta, A. C. (2020). Mindfulness as an effective technique for various psychological problems: A conceptual and literature review. *Journal Of Professionals in Guidance and Counseling*, 1 (1), 1-13. <https://doi.org/10.21831/Progouns.V1i1.30605>.
- Riskesdas. (2018). Hasil Utama Riskesdas. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Saputra, W. N., & Widiyari, S. (2016). Acceptance and commitment therapy: the new wave of cognitive behavior therapy. *Indonesian Journal of School Counseling*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.23916/Schoulid.v1i1.28.1-5>.
- Zhang, & Cao, M. (2023). Effect of Mindfulness-Based Interventions on People with Hypertension and Prehypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. *BMC Cardiovascular Disorders*, 23(1), 110-121.
- Zou, Yeung, A., Li, C., Wei, G. X., Chen, K. W., Kinser, P. A., Ren, Z. (2018). Effects of meditative movements on major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of clinical medicine*, 7(8), 195. <https://doi.org/10.3390/jcm7080195>.
- Abat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation. *General Hospital Psychiatry*, 4(1), 33-47.
- Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 125-143. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg015>

- Bishop, S. R., et al. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11(3), 230–241. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bph077>
- Bohlmeijer, E., et al. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction on health-related quality of life in adults: A meta-analysis. *Mindfulness*, 1(3), 128–138.
- Carlson, L. E., et al. (2003). Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. *Psychosomatic Medicine*, 65(4), 571–581. <https://doi.org/10.1097/01.PSY.0000074003.35911.41>
- Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. *Annual Review of Psychology*, 68, 491–516. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-042716-051139>
- Goldberg, S. B., et al. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 59, 52–60. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.011>
- Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 57(1), 35–43. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(03\)00573-7](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7)
- Gu, J., Strauss, C., Bond, R., & Cavanagh, K. (2015). How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies. *Clinical Psychology Review*, 37, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.01.006>
- Hilton, L., et al. (2017). Mindfulness meditation for chronic pain: Systematic review and meta-analysis. *Annals of Behavioral Medicine*, 51(2), 199–213. <https://doi.org/10.1007/s12160-016-9844-2>
- Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78(2), 169–183. <https://doi.org/10.1037/a0018555>
- Hölzel, B. K., et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 191(1), 36–43. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.08.006>

- Hülshager, U. R., Alberts, H. J. E. M., Feinholdt, A., & Lang, J. W. B. (2013). Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 98(2), 310–325. <https://doi.org/10.1037/a0031313>
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144–156. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016>
- Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., et al. (2013). Mindfulness-based therapy: A comprehensive meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 33(6), 763–771. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.05.005>
- Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 78(6), 519–528. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.03.009>
- Lindahl, J. R., et al. (2017). The varieties of contemplative experience: A mixed-methods study of meditation-related challenges in Western Buddhists. *PLOS ONE*, 12(5), e0176239.
- Mehling, W. E., et al. (2012). Body awareness: A phenomenological inquiry into the common ground of mind–body therapies. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 7(1), 6.
- Pascoe, M. C., et al. (2017). Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 74, 1–14.
- Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2013). *Mindfulness-based cognitive therapy for depression*. Guilford Press.
- Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. *Journal of Clinical Psychology*, 62(3), 373–386. <https://doi.org/10.1002/jclp.20237>
- Tang, Y. Y., et al. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 213–225.
- Treleaven, D. A. (2018). *Trauma-sensitive mindfulness: Practices for safe and transformative healing*. W.W. Norton & Company.
- Winbush, N. Y., et al. (2007). Mindfulness-based stress reduction for sleep disturbances: A systematic review. *Journal of Psychosomatic Research*, 62(6), 553–563.



Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S., & Walach, H. (2014). Mindfulness-based interventions in schools—a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 5, 603. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00603>

PROFIL PENULIS



Erni Tri Indarti, S.Kep.,Ns.,M.Kep Kelahiran Nganjuk pada tahun 1987. Telah menyelesaikan Profesi Ners di Universitas Diponegoro pada tahun 2010, serta Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Bekerja sebagai dosen di STIKes satria Bhakti Nganjuk sejak 2010 dengan mengajar Keperawatan Dasar, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis serta Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana. Sejak Tahun 2019 sampai sekarang penulis menjadi sekretaris prodi Program Studi DIII Keperawatan di STIKes Satria Bhakti Nganjuk. Serta aktif terlibat dalam tim peneliti hibah dari Kemeristedikti pada tahun 2019 dan Tahun 2025 dan aktif menulis berbagai buku ajar. Penulis juga aktif dalam organisasi PPNI dan menjadi Ketua DPK PPNI Nganjuk Kota.



Puji Astutik S.Kep.,Ns.,M.Kes Kelahiran Nganjuk pada tahun 1973. Telah menyelesaikan Magister Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Solo pada tahun 2011. Bekerja sebagai dosen di STIKes Satria Bhakti Nganjuk sejak tahun 1996 dengan mengampu mata kuliah keperawatan maternitas di Program Studi Diploma III Keperawatan. Sejak tahun 2018 sampai sekarang penulis menjadi Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.



Sinopsis

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tekanan darah, tetapi juga berhubungan erat dengan stres psikologis dan menurunnya kualitas hidup penderita. Upaya pengelolaan hipertensi selama ini banyak difokuskan pada terapi farmakologis, sementara intervensi nonfarmakologis seperti Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) masih kurang mendapat perhatian, padahal telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif peran MBSR dalam mengurangi stres, menstabilkan tekanan darah, dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Disajikan dengan dasar teori, bukti ilmiah terbaru, serta uraian praktis mengenai mekanisme kerja mindfulness terhadap sistem saraf dan kardiovaskular. Selain itu, buku ini memaparkan strategi implementasi MBSR yang dapat diterapkan dalam praktik klinis maupun komunitas, sehingga memberikan panduan yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, maupun praktisi terapi komplementer.

Melalui pendekatan yang integratif, buku ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam memahami dan mengembangkan intervensi nonfarmakologis yang lebih holistik bagi penderita hipertensi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kualitas hidup mereka.

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tekanan darah, tetapi juga berhubungan erat dengan stres psikologis dan menurunnya kualitas hidup penderita. Upaya pengelolaan hipertensi selama ini banyak difokuskan pada terapi farmakologis, sementara intervensi nonfarmakologis seperti Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) masih kurang mendapat perhatian, padahal telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif peran MBSR dalam mengurangi stres, menstabilkan tekanan darah, dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Disajikan dengan dasar teori, bukti ilmiah terbaru, serta uraian praktis mengenai mekanisme kerja mindfulness terhadap sistem saraf dan kardiovaskular. Selain itu, buku ini memaparkan strategi implementasi MBSR yang dapat diterapkan dalam praktik klinis maupun komunitas, sehingga memberikan panduan yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, maupun praktisi terapi komplementer.

Melalui pendekatan yang integratif, buku ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam memahami dan mengembangkan intervensi nonfarmakologis yang lebih holistik bagi penderita hipertensi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kualitas hidup mereka.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

